

Deuxieme Bulletin statistique de la protection sociale en RDC

Avant-propos

Remerciements

Le Secrétariat général de la protection sociale adresse ses sincères remerciements à l'ensemble des institutions et partenaires dont la mobilisation a rendu possible l'élaboration de ce deuxième Bulletin statistique sur la protection sociale en République démocratique du Congo.

Ce bulletin s'inscrit dans la continuité du premier bulletin publié en 2024. Sa production a reposé, comme pour l'édition précédente, sur la coopération active des institutions nationales chargées de la gestion des régimes et programmes de protection sociale. Le Secrétariat général de la protection sociale adresse en particulier ses remerciements à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État (CNSSAP), au Fonds de solidarité de santé (FSS) et à la Mutuelle de santé des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel (MESP), qui ont transmis les données administratives nécessaires à l'établissement des indicateurs statistiques présentés dans ce bulletin.

Des remerciements sont également adressés au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, au ministère de l'Emploi et du Travail, au ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (MEPST), au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale (MINAS), ainsi qu'à l'Institut national de la statistique (INS), pour leur contribution aux travaux de collecte, de clarification et de validation des données.

Le Secrétariat général de la protection sociale exprime sa gratitude au Bureau de pays de l'Organisation internationale du Travail pour la République démocratique du Congo, dont l'appui technique a accompagné chaque étape de la production de ce bulletin, depuis l'élaboration du cadre méthodologique jusqu'à la finalisation du document.

Ce bulletin a bénéficié d'un appui financier dans le cadre du projet *Bâtir des socles de protection sociale pour tous — Appui à la deuxième phase du programme phare mondial de l'OIT*, financé par les gouvernements du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg. Le Secrétariat général de la protection sociale leur témoigne sa profonde reconnaissance pour leur soutien constant au renforcement du système de protection sociale en République démocratique du Congo.

La qualité des informations produites dans ce bulletin est le reflet de l'engagement collectif de ces institutions et partenaires. Le Secrétariat général de la protection sociale demeure convaincu que la consolidation progressive du système statistique national de protection sociale constitue un levier essentiel pour éclairer les décisions de politique publique et mieux rendre compte de la situation réelle des personnes couvertes en République démocratique du Congo.

Liste des sigles et acronymes

Sigle	Signification
AT/MP	Accidents du travail et maladies professionnelles
BIT	Bureau international du Travail
CNSS	Caisse Nationale de Sécurité Sociale
CNSSAP	Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publics de l'État
CSU	Couverture Santé Universelle
FNPSS	Fonds National de Promotion et de Service Social
INS	Institut National de la Statistique
ODD	Objectif de développement durable
OIT	Organisation internationale du Travail
OMS	Organisation mondiale de la Santé
PIB	Produit intérieur brut
PNPS	Politique nationale de protection sociale
RDC	République démocratique du Congo
SESOPA	Service de Sécurité Sociale des Parlementaires
SNPS	Stratégie nationale de protection sociale
USD	Dollar des États-Unis

Table des matières

[Clic droit → Mettre à jour les champs pour générer cette liste]

Listes des tableaux, graphiques et encadrés

Liste des tableaux

►	Tableau 2.1 — Sécurité sociale contributive obligatoire : CNSS et CNSSAP	18
►	Tableau 2.2 — Régimes spéciaux (financement par allocation budgétaire)	19
►	Tableau 2.3 — Protection de la santé par segment de population.....	20
►	Tableau 2.4 — Programmes d'assistance sociale et initiatives non contributives (actifs au 31.12.2025).....	21
►	Tableau 2.5 — Politiques sectorielles à dimension protectrice — mention contextuelle (Niveau 3).....	22
►	Tableau 4.1 — Bénéficiaires de pensions de vieillesse, CNSS et CNSSAP (2019–2025) [src]	24
►	Tableau 4.2 — Adéquation des pensions de vieillesse, CNSS (2019–2025) [src]	24
►	Tableau 4.3 — Employeurs enregistrés et cotisants actifs, CNSS et CNSSAP (2019–2025) [src]	25
►	Tableau 4.4 — Bénéficiaires de prestations maternité, CNSS (2019–2025) [src]	25
►	Tableau 4.5 — Bénéficiaires de rentes d'accidents du travail et maladies professionnelles, CNSS (2019–2025) [src]	25
►	Tableau 4.6 — Enfants couverts par les allocations familiales, CNSS et CNSSAP (2019–2025) [src]	26
►	Tableau 4.7 — Montant de l'allocation familiale CNSS et seuil de pauvreté de référence (2019–2025) [src].....	26
►	Tableau 4.8 — Programmes non contributifs ciblant les enfants et les familles [src] ...	27
►	Tableau 4.9 — Bénéficiaires de pensions d'invalidité, CNSS et CNSSAP (2019–2025) [src]	27
►	Tableau 4.10 — Adéquation de la pension d'invalidité CNSS et seuil de pauvreté (2019–2025) [src]	27
►	Tableau 4.11 — Programmes non contributifs pour les personnes handicapées [src].	28
►	Tableau 4.12 — Bénéficiaires de prestations de survie, CNSS et CNSSAP (2019–2025) [src]	28
►	Tableau 4.13 — Adéquation des pensions de survie CNSS et seuil de pauvreté (2019–2025) [src]	28
►	Tableau 4.14 — Indicateurs de couverture FSS (2019–2025)	29
►	Tableau 4.15 — Indicateurs de couverture MESP (2019–2025).....	29
►	Tableau 4.16 — Recettes des régimes contributifs (2019–2025) [src]	30
►	Tableau 4.17 — Dépenses de prestations par institution (2019–2025) [src]	30
►	Tableau 4.18 — Dépenses administratives et ratio d'efficience (2019–2025) [src]	31
►	Tableau 4.19 — Dépenses de protection sociale en proportion du PIB (2019–2025) [src]	31
►	Tableau 5.1 — Définitions des sous-indicateurs de l'ODD 1.3.1 [src].....	32
►	Tableau 5.2 — Valeurs de l'ODD 1.3.1 pour la RDC par groupe de population (2019–2025) [src]	32

►	Tableau 5.3 — Comparaison régionale et internationale de l'ODD 1.3.1 [src]	33
►	Tableau 5.4 — Trajectoire et objectifs de l'indicateur ODD 1.3.1 pour la RDC [src]	33
►	Tableau 5.5 — Évolution de l'indice ODD 3.8.1 pour la RDC (2015–2023) [src]	33
►	Tableau 5.6 — Comparaison régionale et internationale de l'ODD 3.8.1 [src]	34
►	Tableau 5.7 — Trajectoire et objectifs de l'indicateur ODD 3.8.1 pour la RDC [src]	34

Liste des graphiques

►	Figure 1 — Évolution de la population totale, urbaine et rurale de la RDC (1950–2025)8	
►	Figure 2 — Pyramide des âges de la RDC (2025) : répartition de la population par groupe d'âge quinquennal et par sexe.....	9
►	Figure 4 — Évolution du taux de croissance annuel du PIB en RDC (2000–2024)	10
►	Figure 5 — Marché du travail en RDC : taux d'activité et emploi informel par sexe.....	11
►	Figure 6 — Structure de l'emploi par grand secteur d'activité (agriculture, industrie, services), RDC	12

Liste des encadrés

Liste des annexes statistiques

[À compléter]

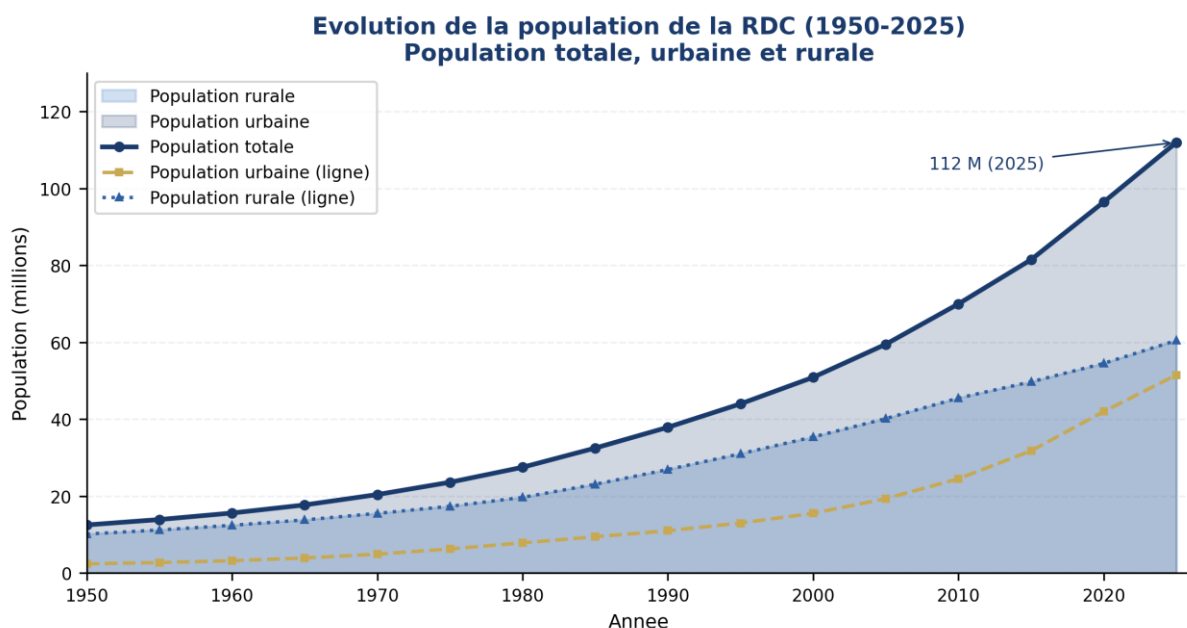
Chapitre 1 — Contexte général et cadre de référence pour la protection sociale en RDC

1.1 Contexte démographique et implications pour la protection sociale

Une population en forte croissance

La République Démocratique du Congo est l'un des pays les plus peuplés d'Afrique, avec une population estimée à environ 112 millions d'habitants¹ en 2025. Sa croissance démographique soutenue — avec un taux d'accroissement naturel annuel d'environ 3,2 %² — en fait l'un des pays à la démographie la plus dynamique du continent. À ce rythme, les projections indiquent un doublement de la population dans les prochaines décennies, ce qui place la RDC au 4e rang africain³ par la taille de sa population, après le Nigeria, l'Éthiopie et l'Égypte (*Division de la population des Nations Unies, WPP 2024*).

► Figure 1 — Évolution de la population totale, urbaine et rurale de la RDC (1950–2025)



Source : *Division de la population des Nations Unies, Perspectives mondiales de la population 2024 (WPP 2024)*⁴.

Une population jeune, portée par des besoins de cycle de vie

La population congolaise est structurellement jeune : les personnes âgées de moins de 15 ans représentent environ 46 %⁵ de la population totale, et l'âge médian s'établit à 15,9 ans⁶ (*UNFPA, 2024 ; Division de la population des Nations Unies, WPP 2024*). Le ratio de dépendance démographique atteint près de 96 dépendants pour 100 personnes en âge de travailler⁷, ce qui

¹ Source : Division de la population des Nations Unies (2024) — Perspectives mondiales de la population 2024

² Source : Division de la population des Nations Unies (2024) — Perspectives mondiales de la population 2024

³ Source : Division de la population des Nations Unies (2024) — Perspectives mondiales de la population 2024

⁴ Données : population totale, urbaine, rurale RDC 1950-2025 — ONU WPP 2024

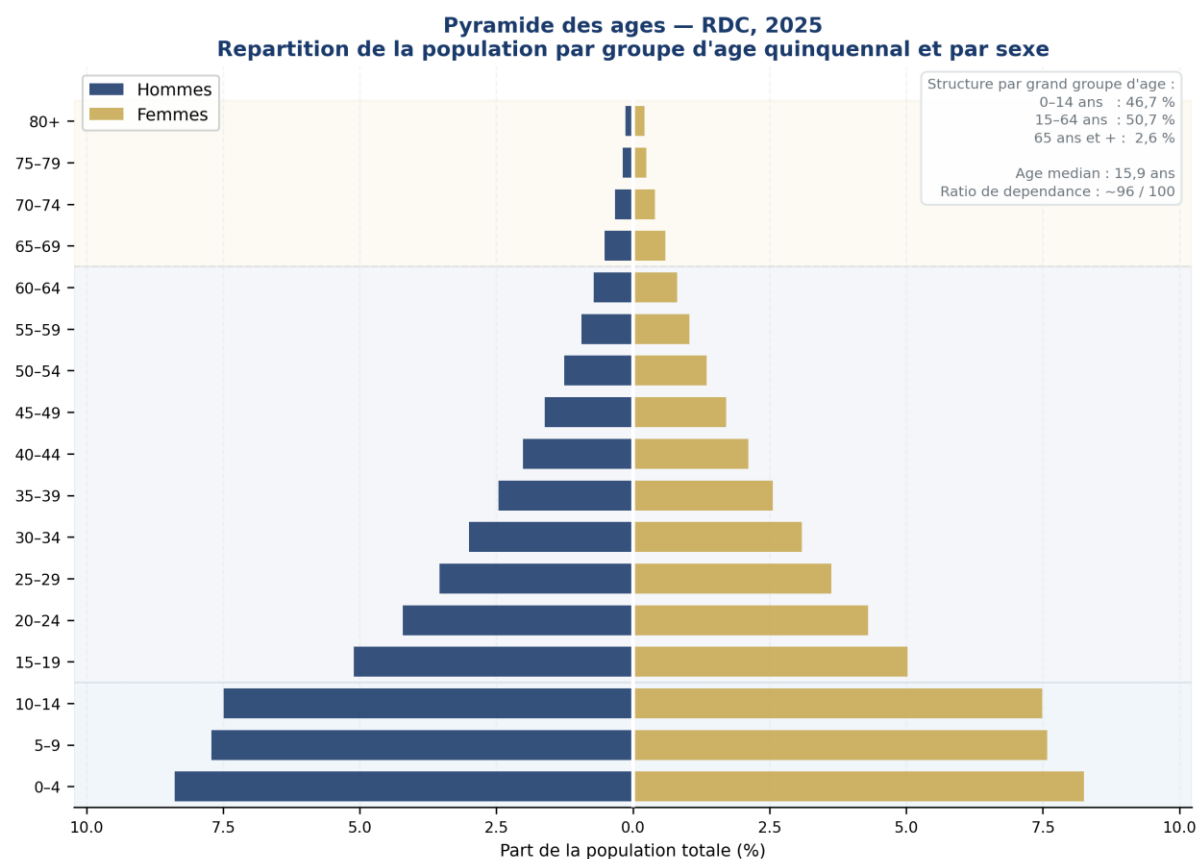
⁵ Source : UNFPA (2024) — World Population Dashboard RDC 2024

⁶ Source : Division de la population des Nations Unies (2024) — Perspectives mondiales de la population 2024

⁷ Source : Division de la population des Nations Unies (2024) — Perspectives mondiales de la population 2024

signifie qu'une proportion élevée de la population est composée de personnes non actives — enfants, jeunes et personnes âgées — dont les besoins en prestations sociales (protection de la maternité, prestations familiales, soins de santé, pensions) sont particulièrement importants.

► **Figure 2 — Pyramide des âges de la RDC (2025) : répartition de la population par groupe d'âge quinquennal et par sexe**



Source : Division de la population des Nations Unies, WPP 2024 / UNFPA. Effectifs approximatifs d'après les tables WPP 2024 standard — estimation mi-2025.⁸

Une urbanisation rapide sur fond de ruralité persistante

Entre 1950 et 2024, la part de la population vivant en milieu urbain est passée de 19 %⁹ à environ 45 %¹⁰ (*Banque mondiale, WDI 2024*). Cette urbanisation accélérée transforme les besoins sociaux dans les grandes agglomérations, en premier lieu à Kinshasa qui compte environ 17 millions d'habitants¹¹ (*ONU WPP 2024*), troisième agglomération africaine et plus grande ville francophone du monde. Elle ne doit cependant pas masquer la persistance d'une population majoritairement rurale : environ 55 %¹² des Congolais vivent encore dans des zones éloignées des grands centres (*Banque mondiale WDI, 2024*), avec une densité moyenne de 51 habitants par km²¹³ sur un territoire de plus de 2,3 millions de km², mais des disparités provinciales considérables.

⁸ Données : pyramide des âges RDC 2025 par sexe — ONU WPP 2024

⁹ Source : Division de la population des Nations Unies (2024) — Perspectives mondiales de la population 2024

¹⁰ Source : Banque mondiale — WDI (2024), d'après WUP 2025 Revision (Nations Unies)

¹¹ Source : Division de la population des Nations Unies (2024) — Perspectives mondiales de la population 2024

¹² Source : Banque mondiale — WDI (2024), d'après WUP 2025 Revision (Nations Unies)

¹³ Source : Division de la population des Nations Unies (2024) — Perspectives mondiales de la population 2024

Premiers enseignements pour la protection sociale

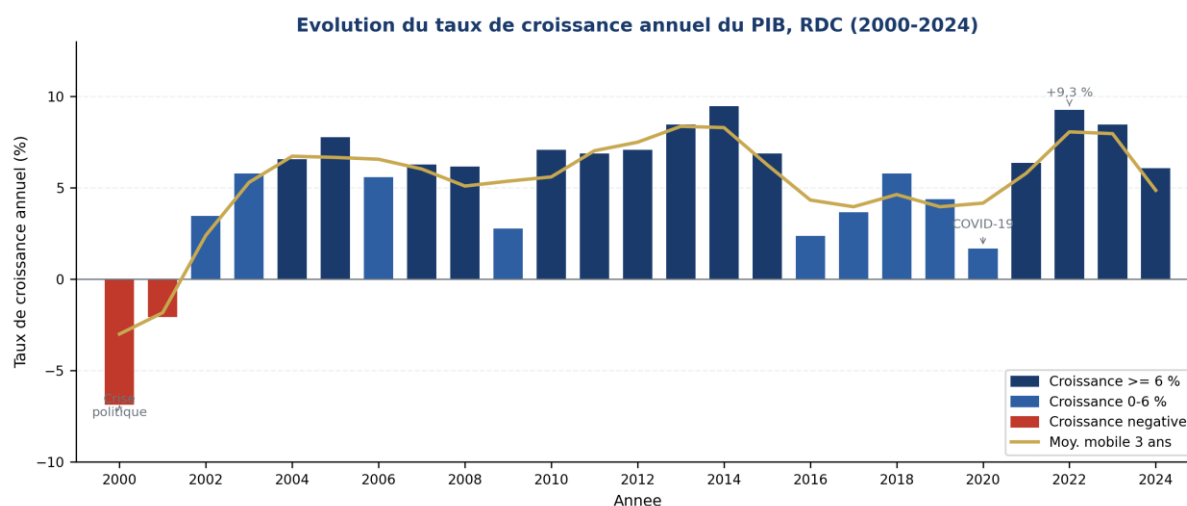
Ces caractéristiques démographiques — forte croissance, population jeune, dualisme urbain-rural — définissent l'ampleur du défi auquel fait face le système de protection sociale congolais. Le nombre de personnes potentiellement éligibles aux différentes branches de couverture est considérable, tandis que la dispersion géographique de la population complique l'accès aux prestations et l'enregistrement des bénéficiaires. Ces constats, combinés aux données économiques présentées dans la section suivante, permettront d'apprécier plus finement les conditions dans lesquelles l'extension de la couverture devra se réaliser.

1.2 Contexte économique, emploi et enjeux d'extension de la couverture

Une croissance soutenue sur fond de fragilité économique

La République Démocratique du Congo a enregistré des taux de croissance économique élevés au cours des dernières années : +6,4 % en 2021¹⁴, +9,3 % en 2022¹⁵, +8,5 % en 2023¹⁶ et +6,1 % en 2024¹⁷ (*Banque mondiale, WDI 2026*). Cette dynamique est largement portée par le secteur minier, qui concentre d'importants gisements de cuivre, cobalt, or, diamants et coltan. Elle ne se traduit cependant pas par une amélioration sensible du niveau de vie moyen : le PIB par habitant s'établissait à 649 USD en 2024¹⁸ (USD courants), parmi les plus bas du continent. Les inégalités restent marquées — l'indice de Gini s'établissait à 0,447 en 2020¹⁹ (*Banque mondiale, WDI — enquête ménages 2020 ; l'enquête INS 2024 indique une valeur de 0,381, non encore intégrée dans les bases internationales*) — et le taux de pauvreté atteignait 69 % de la population²⁰ selon le seuil national (*Banque mondiale, mars 2026, citant enquête INS 2024*). Ces données soulignent la persistance d'une vulnérabilité économique structurelle.

► Figure 4 — Évolution du taux de croissance annuel du PIB en RDC (2000–2024)



Source : Banque mondiale, World Development Indicators (WDI, avril 2026)²¹.

¹⁴ Source : Banque mondiale — WDI (2024) — Croissance du PIB, RDC

¹⁵ Source : Banque mondiale — WDI (2024) — Croissance du PIB, RDC

¹⁶ Source : Banque mondiale — WDI (2024) — Croissance du PIB, RDC

¹⁷ Source : Banque mondiale — WDI (2024) — Croissance du PIB, RDC

¹⁸ Source : Banque mondiale — WDI (2024) — PIB par habitant, RDC

¹⁹ Source : Banque mondiale — WDI — Gini 2020 ; enquête INS 2024 : 38,1

²⁰ Source : Banque mondiale (2026, citant enquête INS 2024) — 69 % de la population sous le seuil national

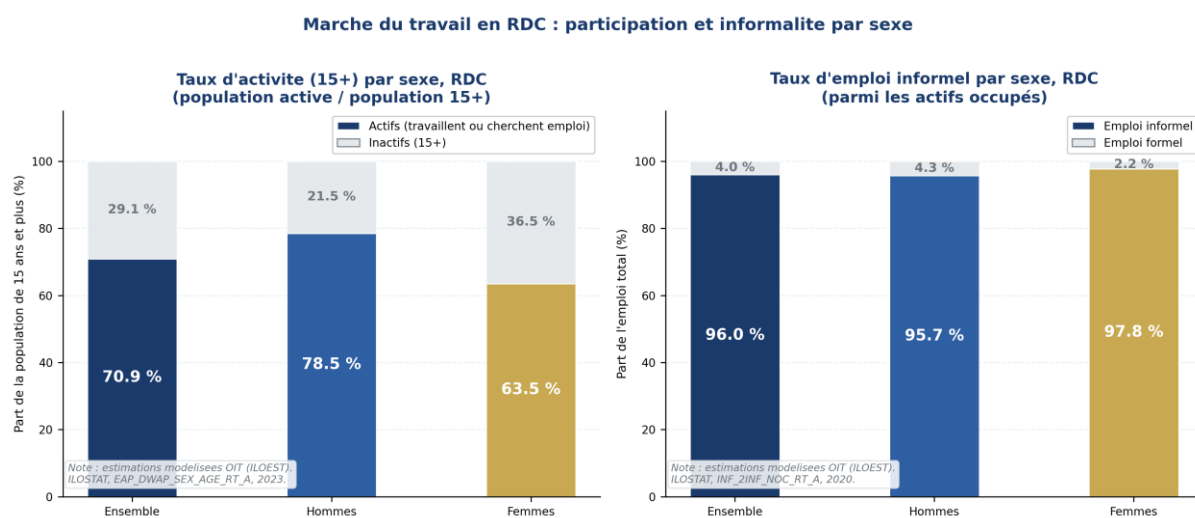
²¹ Données : croissance PIB RDC 2000-2024 — Banque mondiale WDI

Un marché du travail dominé par l'informalité

La population active — c'est-à-dire les personnes de 15 ans et plus qui travaillent ou qui recherchent un emploi — représente environ 70,9 % de la population en âge de travailler en RDC (OIT, ILOSTAT, estimations modélisées, 2023). Ce taux d'activité masque cependant une forte disparité entre les sexes : il atteint 78,5 % chez les hommes, contre 63,5 % chez les femmes, ces dernières étant plus fréquemment maintenues hors du marché du travail visible.

Au sein de cette population active, la structure du marché du travail est marquée par la prédominance écrasante de l'emploi informel et de l'agriculture de subsistance. Selon les estimations modélisées de l'OIT (ILOEST) relayées par la Banque mondiale, environ 59 % de la population active²² travaille dans l'agriculture en 2024, avec une part nettement plus élevée chez les femmes (68 %) que chez les hommes (50 %) (Banque mondiale WDI, indicateur ILOEST, 2024). Malgré un taux de chômage officiel relativement faible — estimé à 4,4 %²³ en 2024 (Banque mondiale WDI, modèle ILO) —, la grande majorité des actifs occupés exercent dans des conditions précaires : le taux d'emploi informel est estimé à environ 96 %²⁴ selon les estimations modélisées de l'OIT (ILOSTAT, données 2020), avec une légère prépondérance chez les femmes (97,8 %²⁵) par rapport aux hommes (95,7 %²⁶). Cette informalité concerne toutes les catégories de statut dans l'emploi : travailleurs indépendants, employés et employeurs. La combinaison d'un taux d'activité inférieur chez les femmes et d'une informalité légèrement plus élevée explique leur moindre représentation dans les régimes contributifs de protection sociale.

► Figure 5 — Marché du travail en RDC : taux d'activité et emploi informel par sexe



Source : OIT, ILOSTAT — estimations modélisées (ILOEST). Taux d'activité (15+) : indicateur EAP_DWAP_SEX_AGE_RT_A, 2023.²⁷ Emploi informel : indicateur INF_2INF_NOC_RT_A, 2020.²⁸

²² Source : Banque mondiale — WDI (2024) — Emploi agricole, RDC. Total : 58,9 %, femmes : 67,8 %, hommes : 50,3 %

²³ Source : Banque mondiale — WDI (2024) — Taux de chômage modèle ILO, RDC

²⁴ Source : OIT, ILOSTAT — Estimations modélisées de l'emploi informel, RDC (données 2020) ; proxys WDI 2024 : emploi vulnérable 81,8 %, travailleurs indépendants 85,3 %

²⁵ Source : OIT, ILOSTAT — Emploi informel par sexe, RDC (2020)

²⁶ Source : OIT, ILOSTAT — Emploi informel par sexe, RDC (2020)

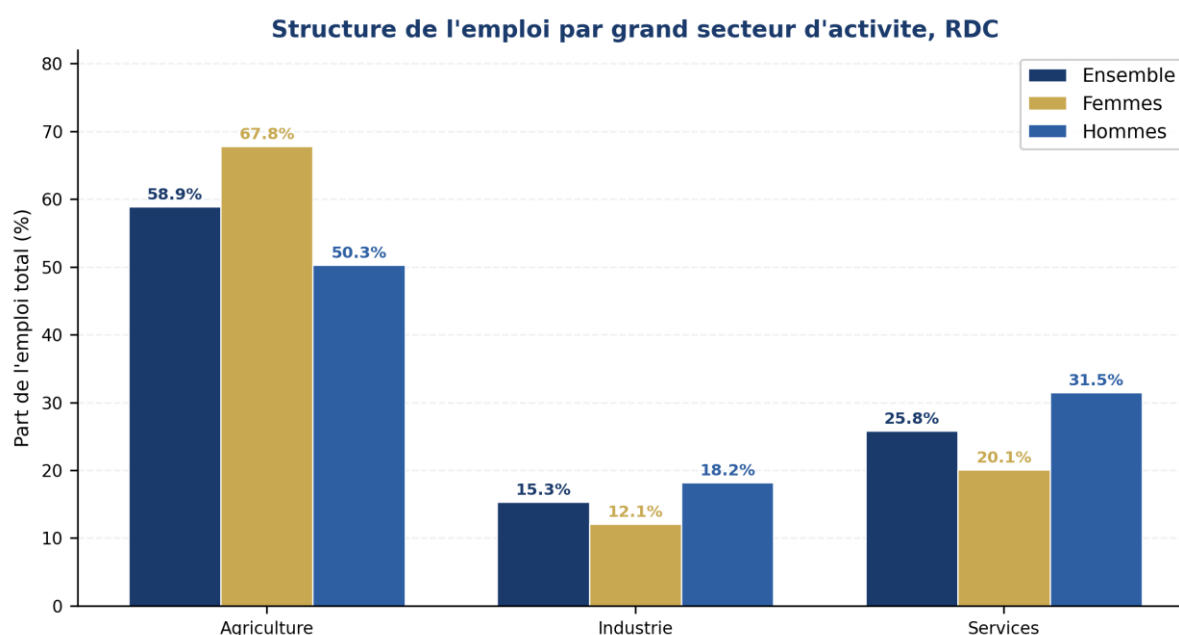
²⁷ Données : taux d'activité 15+ par sexe, RDC 2023 — OIT ILOSTAT

²⁸ Données : emploi informel par sexe, RDC 2020 — OIT ILOSTAT

Des secteurs exposés à des risques professionnels spécifiques

L'économie congolaise concentre des activités à forte exposition aux risques professionnels. Le secteur minier artisanal et industriel emploie plusieurs centaines de milliers de travailleurs dans des conditions souvent difficiles, avec des risques d'accidents du travail, de maladies professionnelles et d'exposition à des substances dangereuses. Le secteur agricole, qui mobilise la majorité de la main-d'œuvre active, est lui aussi exposé à des risques liés aux conditions de travail en milieu rural. Ces réalités renforcent l'importance d'un suivi statistique rigoureux des affiliés, des cotisants actifs et des victimes d'accidents du travail.

► Figure 6 — Structure de l'emploi par grand secteur d'activité (agriculture, industrie, services), RDC



Source : Banque mondiale, WDI (indicateur ILOEST, 2024). Industrie et services : parts résiduelles estimées.²⁹

Les enjeux d'extension de la couverture contributive

Dans ce contexte — forte informalité, bas revenus, vulnérabilité persistante —, l'extension de la protection sociale se heurte à des contraintes structurelles importantes. La majorité des travailleurs n'est pas enregistrée auprès des régimes contributifs formels, ce qui limite à la fois l'assiette de cotisation des institutions et l'accès effectif aux prestations pour les assurés potentiels. Ces constats, croisés avec les données démographiques de la section précédente, éclairent les orientations stratégiques que la RDC s'est données pour répondre à ces défis, présentées dans la section suivante.

1.3 Protection sociale, stratégie nationale et besoin de données statistiques

La protection sociale face aux risques et vulnérabilités

Dans un contexte marqué par une forte croissance démographique, une économie dominée par l'emploi informel et un niveau de revenu par habitant encore très bas, la population congolaise

²⁹ Données : emploi par secteur RDC 2024 — Banque mondiale WDI / ILOEST

reste largement exposée aux risques sociaux tout au long du cycle de vie : maternité, maladie, accidents du travail, invalidité, vieillesse, perte d'un soutien de famille. L'exposition de nombreux ménages à des chocs économiques, climatiques ou sécuritaires amplifie ces vulnérabilités. La protection sociale, entendue comme l'ensemble des politiques et programmes visant à réduire et prévenir la pauvreté et la vulnérabilité³⁰ (BIT, 2024), constitue dans ce cadre une réponse structurelle dont l'organisation et l'extension sont des enjeux prioritaires pour la RDC. À l'échelle mondiale, seulement 52,4 % de la population mondiale³¹ bénéficient d'au moins une prestation de protection sociale, et ce taux tombe à 19,1 % en Afrique³² (BIT, 2024), soulignant l'ampleur des défis communs à la RDC et à son environnement régional.

Les engagements stratégiques de la RDC

La RDC s'est dotée d'un cadre stratégique national pour répondre à ces défis. La Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS), instituée par le décret présidentiel n°05/176 du 24 novembre 2005, fixe une vision à l'horizon 2030 : « à l'horizon 2030, le Congo est une Nation solidaire, soucieuse d'équité, promotrice de bien-être, une Nation qui protège efficacement les couches sociales les plus vulnérables et les plus démunies »³³ (RDC, 2016). Elle s'articule autour de trois axes stratégiques complémentaires : la promotion de l'accès aux services sociaux de base et à une sécurité élémentaire de revenus pour les personnes vulnérables ; le renforcement et l'extension des systèmes d'assurance sociale ; et le renforcement du cadre institutionnel, des capacités et du financement de la protection sociale. La mise en place progressive de la Couverture Sanitaire Universelle, déclinée dans le Plan stratégique national CSU 2021-2030, s'inscrit dans ce même élan. Ces engagements rejoignent les normes internationales auxquelles la RDC a souscrit, notamment la Convention n°102 de l'OIT sur la sécurité sociale (*ratifiée en 1987*) et la Recommandation n°202 sur les socles de protection sociale (OIT, 2012).

Des contraintes structurelles à prendre en compte

La mise en œuvre de ces orientations stratégiques se heurte à des contraintes bien documentées. La très forte prévalence de l'emploi informel réduit mécaniquement l'assiette des régimes contributifs et limite l'enregistrement des affiliés potentiels. Les capacités de financement public restent sous pression dans un contexte de besoins sociaux considérables. La dispersion géographique de la population, dans un pays de plus de 2,3 millions de km², complique l'accès aux prestations et l'organisation de la collecte des données. Ces contraintes ne remettent pas en cause la pertinence de la stratégie nationale, mais elles en conditionnent le rythme et les modalités de mise en œuvre.

Le bulletin comme instrument d'aide à la décision

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent bulletin. La production régulière de statistiques de protection sociale constitue un outil essentiel pour orienter les choix de politique publique sur la base de données factuelles. Ce deuxième bulletin statistique vise à consolider les informations disponibles sur les régimes, institutions et programmes de protection sociale en RDC, à mesurer les niveaux de couverture effective — notamment au regard de l'indicateur ODD 1.3.1 — et à identifier les lacunes qui devront être prises en compte dans l'élaboration et le

³⁰ Source : Bureau International du Travail (2024) — Rapport mondial sur la protection sociale 2024-26

³¹ Source : BIT (2024) — 52,4 % de la population mondiale couverte par au moins une prestation

³² Source : BIT (2024) — 19,1 % de la population africaine couverte par au moins une prestation

³³ Source : Gouvernement de la RDC (2016) — Stratégie nationale de la protection sociale (SNPS)

suivi de la stratégie nationale. Il couvre la période jusqu'à décembre 2025 et s'appuie sur les données transmises par les institutions nationales, les publications des organisations internationales et les registres administratifs disponibles. Le chapitre 1 présente le cadre conceptuel et les choix méthodologiques qui fondent cette démarche.

Chapitre 2 — Cadre conceptuel et périmètre statistique

2.1 Définitions et approches de la protection sociale

La protection sociale comme droit fondamental

La protection sociale désigne l'ensemble des mécanismes permettant aux individus et aux ménages de faire face aux risques et aux vulnérabilités susceptibles de réduire leurs revenus ou d'alourdir leurs dépenses essentielles. Elle est reconnue comme un droit fondamental par l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948)³⁴, qui reconnaît à toute personne, en tant que membre de la société, le droit à la sécurité sociale. L'article 25 du même texte précise que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, notamment en cas de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse, ou dans tout autre cas de perte de moyens de subsistance.³⁵

Trois approches complémentaires

Plusieurs approches coexistent pour traduire ce droit en systèmes concrets. La première est celle de la sécurité sociale au sens normatif, posée par la Convention no 102 de l'OIT sur la sécurité sociale (normes minimales), adoptée en 1952³⁶. Cette convention identifie neuf branches de risques : les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de chômage, les pensions de vieillesse, les prestations en cas d'accidents du travail ou de maladie professionnelle, les allocations familiales, les prestations de maternité, les pensions d'invalidité et les pensions de survivants. Elle constitue la référence normative minimale en matière de sécurité sociale à l'échelle internationale.

La deuxième approche, complémentaire de la première, est celle des socles de protection sociale, formalisée par la Recommandation no 202 de l'OIT, adoptée à l'unanimité en 2012³⁷. Elle invite les États à garantir à l'ensemble de leur population un niveau de base de sécurité sociale tout au long du cycle de vie, articulé autour de quatre garanties minimales : l'accès aux soins de santé essentiels, une sécurité de revenu de base pour les enfants, une sécurité de revenu pour les personnes en âge actif dans l'incapacité de travailler, et une sécurité de revenu pour les personnes âgées. Ce plancher universel est pensé comme un point de départ à partir duquel des niveaux plus élevés de protection peuvent être progressivement construits, en cohérence avec les ressources et les priorités de chaque pays.

Une troisième acception, plus large, est mobilisée dans les stratégies nationales de développement social. Elle englobe les programmes d'assistance sociale ciblés sur les populations vulnérables, les politiques d'accès aux services sociaux de base et les dispositifs de réponse aux crises. Cette conception rejoint les engagements internationaux formalisés dans les Objectifs de développement durable, notamment l'indicateur ODD 1.3.1, qui mesure la proportion de la population couverte par des socles ou des systèmes de protection sociale.

³⁴ Source : OIT (2021) Building social protection systems : International standards and human rights instruments

³⁵ Source : OIT (2021) — Building social protection systems — DUDH (1948), art. 25 : droit à un niveau de vie suffisant

³⁶ Source : OIT Convention no 102 sur la sécurité sociale (normes minimales), 1952

³⁷ Source : OIT Recommandation no 202 sur les socles de protection sociale, 2012

2.2 Approche retenue pour le bulletin : cadre BIT/OIT et indicateurs de couverture effective

L'approche BIT/OIT : une grille normative et statistique

Le présent bulletin retient comme cadre principal l'approche du Bureau international du Travail (BIT) et de l'Organisation internationale du Travail (OIT). Ce cadre organise la protection sociale autour de notions directement mesurables³⁸ — régimes, branches de risques couvertes, personnes affiliées, cotisants actifs, bénéficiaires, prestations servies et dépenses — permettant de construire des indicateurs comparables dans le temps et entre systèmes. Il couvre à la fois les régimes contributifs, les dispositifs non contributifs et la protection de la santé, sans réduire la protection sociale à l'assistance sociale ou aux transferts ciblés. Il correspond enfin aux engagements internationaux de la RDC : Convention no 102 de l'OIT (ratifiée en 1987)³⁹ et indicateur ODD 1.3.1, dont la méthodologie est harmonisée par le BIT⁴⁰.

Ce que le bulletin mesure et ce qu'il documente sans mesurer

Le bulletin distingue deux niveaux de traitement des dispositifs. Sont intégrés dans les indicateurs statistiques les régimes et programmes pour lesquels il est possible d'identifier des personnes couvertes, des prestations servies et des dépenses. Sont documentés à titre contextuel les dispositifs pour lesquels ces données ne sont pas disponibles ou ne permettent pas d'identifier un bénéficiaire individualisable. Cette distinction traduit une contrainte statistique, non un jugement sur l'importance des dispositifs.

2.4 Grilles de lecture : classification des régimes, programmes et prestations

Le bulletin distingue deux notions fondamentales, non interchangeables. La couverture légale désigne les personnes auxquelles un régime est applicable selon les textes en vigueur. La couverture effective désigne les personnes réellement protégées, mesurées par les données administratives ou d'enquête. La couverture effective est un sous-ensemble de la couverture légale ; c'est elle qui constitue le principal objet de mesure du bulletin.

Les dispositifs sont analysés selon quatre dimensions complémentaires : le caractère obligatoire ou volontaire de l'affiliation ; la nature du financement (contributif ou non contributif) ; le statut réglementaire (statutaire ou non) ; la nature des prestations (en espèces ou en nature). Ces dimensions s'appliquent à l'ensemble des régimes cartographiés au chapitre 3. Les conditions d'accès — affiliation et cotisation, statut professionnel, condition de ressources, ciblage catégoriel ou résidence — sont précisées pour chaque dispositif.

→ *Les définitions complètes et les grilles de classification détaillées sont développées en Annexe A.2 — Classification des régimes, programmes et prestations.*

³⁸ Source : OIT (2021) Building social protection systems : International standards and human rights instruments

³⁹ Source : OIT — Convention no 102 sur la sécurité sociale (normes minimales), 1952 — ratifiée par la RDC en 1987 (Parties V, VII, IX, X)

⁴⁰ Source : BIT (2024) — Rapport mondial sur la protection sociale 2024-26 — définition et méthodologie de l'indicateur ODD 1.3.1

2.5 Précautions de lecture : distinctions statistiques et limites méthodologiques

La lecture des indicateurs du bulletin suppose quelques distinctions que l'usage courant tend à confondre. Un affilié n'est pas nécessairement un cotisant actif : l'affiliation peut précéder la première cotisation ou persister après une interruption. Un bénéficiaire (ayant reçu une prestation) n'est pas une personne couverte (ayant droit à une prestation si le risque se réalise). Une même personne peut recevoir plusieurs prestations dans l'année : le dénombrement de prestations servies n'équivaut pas à un décompte de personnes distinctes. Lorsque les résultats sont exprimés en ménages bénéficiaires, la conversion en individus couverts repose sur des hypothèses de taille de ménage documentées dans le bulletin. La distinction entre couverture légale et couverture effective, centrale pour l'ensemble du bulletin, est rappelée à chaque indicateur concerné.

Les limites générales du bulletin sont de trois ordres. La disponibilité des données administratives reste inégale selon les institutions et les périodes. La complétude des données transmises peut varier selon les exercices. La désagrégation — par sexe, âge, province ou secteur — n'est pas systématiquement disponible et est indiquée au cas par cas.

→ *Les définitions opérationnelles complètes figurent dans le Glossaire.*

Chapitre 3 — Cartographie institutionnelle de la protection sociale en RDC

3.1 Panorama des régimes et programmes de protection sociale en RDC

Vue d'ensemble

Sur la base des grilles définies au chapitre 2 — couverture légale et effective, caractère obligatoire ou volontaire, financement contributif ou non contributif, statut réglementaire, nature des prestations et conditions d'accès —, le présent chapitre cartographie les régimes, programmes et institutions de protection sociale identifiés en RDC à la date de rédaction.

Cette cartographie distingue quatre grandes catégories : la sécurité sociale contributive obligatoire, qui couvre les travailleurs du secteur formel selon leurs catégories (Tableaux 2.1 et 2.2) ; la protection de la santé, organisée par segment de population (Tableau 2.3) ; les programmes d'assistance sociale et initiatives non contributives destinés aux populations non couvertes par les régimes formels (Tableau 2.4) ; enfin, un ensemble de politiques sectorielles à dimension protectrice — gratuités, programmes d'activation par l'emploi, accès subventionné aux services de base — dont la finalité sociale est établie mais qui ne relèvent pas à proprement parler de l'assistance sociale (Tableau 2.5, mention contextuelle).

Sécurité sociale contributive obligatoire

Les neuf branches de la Convention no 102 de l'OIT⁴¹ servent de grille de lecture pour situer chaque institution dans le panorama de la protection sociale.

► Tableau 2.1 — Sécurité sociale contributive obligatoire : CNSS et CNSSAP

	CNSS ⁴²	CNSSAP ⁴³
Population assujettie	Travailleurs du secteur privé formel et assimilés [1] ⁴⁴	Agents de carrière, militaires, policiers, enseignants, contractuels de l'État [2] ⁴⁵
Caractère	Obligatoire, statutaire	Obligatoire, statutaire
Mode de financement	Cotisations employeur + salarié [1] ⁴⁶	Cotisations État employeur + agent [2] ⁴⁷
Base légale principale	Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 [1] ⁴⁸	Décret n°15/031 du 14 déc. 2015 ; Loi n°22/031 du 15 juil. 2022 [2] ⁴⁹
<i>Branche C102</i>		
Soins médicaux (Partie II)	—	—

⁴¹ Source : OIT — Convention no 102 sur la sécurité sociale (normes minimales), 1952

⁴² Source : CNSS RDC — Site officiel cnss.cd, consulté juin 2026

⁴³ Source : CNSSAP RDC — Site officiel cnssap.cd, consulté juin 2026

⁴⁴ CNSS RDC - branches et populations couvertes (cnss.cd, loi n°16/009)

⁴⁵ CNSSAP RDC - branches et populations couvertes (cnssap.cd, décret 15/031, loi 22/031)

⁴⁶ CNSS RDC - branches et populations couvertes (cnss.cd, loi n°16/009)

⁴⁷ CNSSAP RDC - branches et populations couvertes (cnssap.cd, décret 15/031, loi 22/031)

⁴⁸ CNSS RDC - branches et populations couvertes (cnss.cd, loi n°16/009)

⁴⁹ CNSSAP RDC - branches et populations couvertes (cnssap.cd, décret 15/031, loi 22/031)

	CNSS ⁴²	CNSSAP ⁴³
Indemnités de maladie (Partie III)	—	—
Chômage (Partie IV)	—	—
Vieillesse (Partie V)	✓	✓
Accidents du travail / mal. prof. (Partie VI)	✓	✓
Allocations familiales (Partie VII)	✓	✓
Maternité (Partie VIII)	✓	✓
Invalidité (Partie IX)	✓	✓
Survivants (Partie X)	✓	✓

Légende : ✓ = branche couverte de façon effective (données disponibles) — ✓ = branche prévue légalement, données non encore consolidées — — = branche non prévue dans le régime.

Sources : CNSS (cnss.cd, 2026)⁵⁰ · CNSSAP (cnssap.cd, 2026)⁵¹ · Premier bulletin RDC (2023)⁵²

Régimes spéciaux

Les régimes spéciaux couvrent des catégories professionnelles spécifiques de l'État. À l'exception du régime des parlementaires, ces régimes sont en grande partie financés par allocation budgétaire du Trésor public et non par cotisations.

► **Tableau 2.2 — Régimes spéciaux (financement par allocation budgétaire)**

Régime	Population couverte	Mode de financement	Caractère	Branches C102 prévues
Régime des militaires (FAC, PNC)	Forces armées, Police nationale	Allocation budgétaire	Non contributif	Vieillesse ✓, survivants ✓
Régime des magistrats civils	Magistrats du siège et du parquet	Allocation budgétaire	Non contributif	Vieillesse ✓, survivants ✓
Régime des parlementaires	Membres de l'Assemblée nationale et du Sénat	Cotisations + dotation	Mixte	Vieillesse ✓, survivants ✓
Autres régimes budgétaires	Autres catégories spécifiques	Allocation budgétaire	Non contributif	À préciser

Légende : ✓ = branche couverte de façon effective. Note : les branches couvertes par les régimes spéciaux sont identifiées sur base du premier bulletin (2023). La collecte des données effectives fera l'objet de démarches spécifiques dans le cadre du présent bulletin.
Source : Premier bulletin RDC (2023)⁵³

⁵⁰ CNSS RDC - Site officiel cnss.cd et loi n°16/009 du 15 juillet 2016 - branches et populations couvertes

⁵¹ CNSSAP RDC - Site officiel cnssap.cd ; décret n°15/031 du 14 déc. 2015 ; loi n°22/031 du 15 juil. 2022

⁵² Premier bulletin statistique de la protection sociale en RDC (2023) - tableaux 3 à 7

⁵³ Premier bulletin statistique de la protection sociale en RDC (2023) - cartographie institutionnelle des régimes spéciaux

Protection de la santé

La protection de la santé est organisée par segment de population. L'axe principal est la **population bénéficiaire**, ce qui permet de visualiser les lacunes de couverture entre segments.

► **Tableau 2.3 — Protection de la santé par segment de population**

Segment de population	Dispositif	Institution	Caractère	Mode de financement	Statut du dispositif
Travailleurs privé formel + dépendants	FSS — Afia Bora (paquet de base obligatoire) ⁵⁴ [1] ⁵⁵	FSS	Obligatoire	Cotisations employeur/salarié	Opérationnel (2026)
Travailleurs informels + dépendants	FSS — régime informel [1] ⁵⁶	FSS	À confirmer	À confirmer	En déploiement
Mères et nouveau-nés	FSS — Kobota Ofele (gratuité maternité) [1] ⁵⁷	FSS / État	Non contributif	Financement État	Opérationnel (2026)
Couverture complémentaire	FSS — Afia Bora Prime [1] ⁵⁸	FSS	Volontaire	Cotisations	Opérationnel (2026)
Enseignants EPST + dépendants	MESP (Mutuelle agréée) [2] ⁵⁹	MESP	Obligatoire, statutaire	Cotisations membres + État	Opérationnel
Population générale (volontaire)	Mutuelles de santé volontaires (> 200)	Diverses	Volontaire	Cotisations membres	Actif, non consolidé
Militaires, magistrats + dépendants	Régime d'assistance médicale de l'État	Ministère compétent	Non contributif	Allocation budgétaire	Actif

Légende : Opérationnel = dispositif juridiquement institué et fonctionnant à la date de rédaction — En déploiement = cadre légal adopté, mise en œuvre en cours — Actif = dispositif en activité, données non consolidées au niveau national.

Sources : FSS (fss.cd, juin 2026)⁶⁰ · Premier bulletin RDC (2023), tableau 9⁶¹ · Loi n°18/035 (2018) / Décret n°22/13 (2022)⁶²

Note : Les mutuelles volontaires ne sont pas incluses dans les indicateurs de couverture du présent bulletin, conformément aux critères définis en section 2.3.

Programmes d'assistance sociale et initiatives non contributives

Les régimes décrits dans les tableaux précédents reposent sur un fondement contributif ou statutaire permanent. Ils ne couvrent cependant qu'une fraction de la population, principalement celle intégrée dans l'emploi formel ou dans des catégories de fonctionnaires identifiées. La grande majorité de la population congolaise — travailleurs informels, ménages ruraux, déplacés, personnes vulnérables — ne bénéficie d'aucun de ces régimes.

La Recommandation no 202 de l'OIT (2012)⁶³ définit les **socles de protection sociale** comme des garanties élémentaires devant couvrir toute la population, y compris ceux qui ne participent à aucun régime contributif. En RDC, cette fonction est partiellement assurée par un ensemble de

⁵⁴ Source : FSS RDC — Site officiel fss.cd, consulté juin 2026

⁵⁵ FSS RDC - produits et régimes opérationnels (fss.cd, juin 2026)

⁵⁶ FSS RDC - produits et régimes opérationnels (fss.cd, juin 2026)

⁵⁷ FSS RDC - produits et régimes opérationnels (fss.cd, juin 2026)

⁵⁸ FSS RDC - produits et régimes opérationnels (fss.cd, juin 2026)

⁵⁹ Premier bulletin statistique RDC (2023) - tableau 9 : MESP

⁶⁰ FSS RDC - Site officiel fss.cd (juin 2026) - produits et régimes opérationnels

⁶¹ Premier bulletin statistique de la protection sociale en RDC (2023) - tableau 9 : MESP

⁶² CNSSAP RDC - Base légale MESP incluse dans le champ CNSSAP / santé des agents publics

⁶³ OIT — Recommandation no 202 (2012) — §8 : les socles de protection sociale comprennent des garanties minimales pour les populations non couvertes par les régimes contributifs

programmes non contributifs et d'initiatives sectorielles, portés soit par le gouvernement, soit par des partenaires techniques et financiers. [Premier bulletin 2023]⁶⁴

Ces programmes se distinguent des régimes précédents par trois caractéristiques structurelles : ils sont entièrement **financés par des ressources publiques ou des contributions extérieures**, sans cotisation des bénéficiaires ; ils ne confèrent généralement **aucun droit statutaire permanent** susceptible d'être invoqué par les intéressés ; et leur pérennité dépend des décisions budgétaires annuelles ou des cycles de financement des bailleurs. Cette fragilité institutionnelle est une limite importante à leur intégration dans les indicateurs de couverture ; ils sont néanmoins recensés ici car ils constituent, pour les populations concernées, la seule forme de protection sociale accessible.

► **Tableau 2.4 — Programmes d'assistance sociale et initiatives non contributives (actifs au 31.12.2025)**

Programme	Type d'intervention	Population cible	Bailleur principal	Responsable mise en œuvre	Périmètre	Statut au 31.12.2025
PAM — Transferts de ressources sans conditions ⁶⁵ <i>Début : continu (2000s) — Actif au 31.12.2025 [1]⁶⁶</i>	Transferts monétaires et alimentaires inconditionnels	Ménages en insécurité alimentaire ; déplacés internes ; zones de conflit	Donateurs internationaux (UE, USAID, RU...)	PAM	Est DRC (prioritaire) ; national	Actif
PAM — Cantines scolaires ⁶⁷ <i>Début : 2023 (pilote) — Statut 2025 : en cours (données non consolidées) [1]⁶⁸</i>	Transferts en nature (repas nutritifs en milieu scolaire)	Enfants scolarisés dans les écoles publiques	PAM + donateurs	PAM + MEPST	Phase pilote (périmètre à préciser)	Actif (pilote)
UNICEF — Cash + Nutrition ⁶⁹ <i>Début : 2021 (données disponibles) — Actif (intermittent) au 31.12.2025 [2]⁷⁰</i>	Transferts monétaires + soutien nutritionnel	Enfants malnutris ; ménages vulnérables (urgence humanitaire)	UNICEF + donateurs institutionnels	UNICEF + partenaires	Tanganyika (et autres provinces)	Actif (intermittent)

Légende : tableau limité aux programmes actifs à un moment de l'année 2025 (période de référence : 1er janvier au 31 décembre 2025). Les programmes clôturés avant 2025 (STEP, clôture févr. 2024 ; UNICEF+FAO, ponctuel 2022) ne sont pas repris. Les programmes « actifs intermittents » dépendent des financements des bailleurs et peuvent être interrompus entre deux cycles.

Sources : Premier bulletin RDC (2023), ch. 2.3⁷¹ · PAM (wfp.org, 2026)⁷² · UNICEF RDC (2021–2025)⁷³ · R202 (OIT, 2012)⁷⁴
La liste est indicative et non exhaustive. Une cartographie complète des initiatives actives en 2025 dépasse le périmètre du présent chapitre.

⁶⁴ Premier bulletin statistique de la protection sociale en RDC (2023) — ch. 2.3 : programmes non contributifs d'assistance sociale

⁶⁵ PAM — Transferts de ressources sans conditions (TRC) — 4 037 575 bénéficiaires en 2021, 3 795 530 en 2022

⁶⁶ PAM RDC — site officiel wfp.org (consulté juin 2026) et Premier bulletin (2023)

⁶⁷ PAM + MEPST — Programme national de cantines scolaires — phase pilote initiée en 2023 pour consolider la gratuité de l'enseignement primaire

⁶⁸ PAM RDC — cantines scolaires : phase pilote, écoles publiques, objectif nutritionnel et scolarisation

⁶⁹ UNICEF — Cash + Nutrition (Tanganyika) — 226 648 enfants bénéficiaires en 2021 ; programme humanitaire récurrent

⁷⁰ Source : Premier bulletin (2023) citant données UNICEF 2021 — province de Tanganyika

⁷¹ Premier bulletin statistique de la protection sociale en RDC (2023) — ch. 2.3 : cartographie des programmes non contributifs

⁷² PAM — site officiel wfp.org (consulté juin 2026)

⁷³ UNICEF RDC — transferts monétaires humanitaires (2021-2022, actif intermittent)

⁷⁴ OIT — Recommandation no 202 sur les socles de protection sociale (2012)

Politiques sectorielles à dimension protectrice

Au-delà des régimes contributifs et des programmes d'assistance sociale décrits dans les tableaux précédents, le paysage de la protection sociale en RDC comprend un ensemble de dispositifs dont la finalité protectrice est établie, mais qui ne relèvent pas à proprement parler de l'assistance sociale — c'est-à-dire qu'ils n'opèrent pas par transferts individuels ciblés vers des bénéficiaires identifiés. Il s'agit de **politiques sectorielles à dimension protectrice** : politiques de gratuité d'accès à un service public, soins préventifs à portée universelle, et programmes d'activation par l'emploi.

Conformément au cadre méthodologique du présent bulletin (Annexe A.1, Niveau 3), ces dispositifs sont mentionnés à titre contextuel. Leur finalité protectrice est reconnue : ils réduisent une vulnérabilité — éducative, sanitaire ou économique — en supprimant un obstacle financier d'accès ou en créant un revenu transitoire. Ils ne sont cependant pas agrégés dans les indicateurs de couverture car ils ne donnent pas lieu, dans l'état actuel des données disponibles, à des mesures individualisables de personnes protégées.

► **Tableau 2.5 — Politiques sectorielles à dimension protectrice — mention contextuelle (Niveau 3)**

Dispositif	Nature de l'effet protecteur	Population visée	Responsable	Périmètre	Statut au 31.12.2025
Gratuité de l'enseignement primaire public ⁷⁵ <i>Depuis rentrée sept. 2019</i>	Suppression des frais de scolarité — réduction de la vulnérabilité éducative des ménages pauvres	Enfants en âge scolaire (écoles primaires publiques)	MEPST	National	Actif
Gratuité de l'accouchement en formations sanitaires publiques ⁷⁶ <i>Cadre légal antérieur à 2019 — dispositif distinct du FSS Kobota Ofele</i>	Suppression des frais d'accouchement — réduction de la mortalité maternelle et du risque financier lié à la maternité	Femmes enceintes (formations sanitaires publiques)	MSPHPS	National (application variable)	Partiellement opérationnel
Soins préventifs et vaccination (programmes MSPHPS) ⁷⁷ <i>Vaccinations, moustiquaires, kits médicaux, dépistage VIH/TB — continu</i>	Prévention des risques sanitaires — réduction de la vulnérabilité morbide des populations non couvertes par une assurance	Enfants de moins de 5 ans, PVVIH, personnes vulnérables	MSPHPS + partenaires (OMS, UNICEF, GAVI)	National	Actif (données non consolidées)

⁷⁵ Gratuité de l'enseignement primaire — Instruction n°001/MINEPSP/CABMIN/2019 — suppression des frais de scolarité dans les écoles primaires publiques. 18,4 millions de bénéficiaires estimés en 2022 (MEPST).

⁷⁶ Gratuité de la maternité — arrêté ministériel MSPHPS — soins d'accouchement gratuits dans les formations sanitaires publiques. Opérationnalité variable selon les zones et la disponibilité des intrants.

⁷⁷ Premier bulletin (2023), tableau 11 — interventions du MSPHPS : vaccination, kits médicaux, moustiquaires, dépistage VIH/TB. Données de couverture non consolidées.

Dispositif	Nature de l'effet protecteur	Population visée	Responsable	Périmètre	Statut au 31.12.2025
Programmes de travaux à Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO / THIMO) ⁷⁸ <i>Référence principale : composante THIMO du projet STEP — clôturé fév. 2024</i>	Création temporaire d'emplois et de revenus — activation économique des ménages vulnérables en zone de conflit ou post-conflit	Communautés vulnérables accueillant des personnes déplacées	Fonds Social de la RDC + bailleurs (BM / IDA)	Est DRC (provinces de l'Est)	Clôturé (STEP fév. 2024) — successeurs non documentés
Centres de promotion sociale et d'apprentissage professionnel (MINAS) ⁷⁹ <i>Continu — cadre légal : Décret n°05/176 du 24 nov. 2005 (PNPS)</i>	Insertion sociale et professionnelle — réduction de la vulnérabilité des jeunes, personnes handicapées et groupes en situation précaire	Jeunes 9–24 ans ; personnes vivant avec un handicap ; groupes vulnérables	MINAS	National	Actif

Légende : les dispositifs de ce tableau ne sont pas intégrés dans les indicateurs de couverture ODD 1.3.1 du présent bulletin. Leur inscription ici répond à un souci de complétude institutionnelle. Les données chiffrées mentionnées en note sont indicatives ; elles ne constituent pas des indicateurs de couverture effective comparables à ceux du Chapitre 4.

Sources : Premier bulletin RDC (2023), tableaux 10–12⁸⁰ · Programmes gouvernementaux RDC (compilation, juin 2026)⁸¹ · SNPS (Gouvernement RDC, 2016)⁸² · Annexe A.1 du présent bulletin (cadre méthodologique, Niveau 3)⁸³

⁷⁸ THIMO — composante travaux publics du projet STEP (Fonds Social RDC / Banque mondiale) — 150 000 personnes ciblées dans les provinces de l'Est. Projet STEP clôturé en février 2024. Éventuels programmes HIMO successeurs non documentés à la date de rédaction.

⁷⁹ Premier bulletin (2023), tableau 12 — MINAS : Centres de promotion sociale (812 540 bénéficiaires en 2022), Centres d'apprentissage professionnel pour PHV (214 152 bénéficiaires en 2022).

⁸⁰ Premier bulletin statistique de la protection sociale en RDC (2023) — tableaux 10, 11, 12 : gratuité éducation, interventions MSPHPS et MINAS

⁸¹ Programmes gouvernementaux non contributifs RDC — MEPST, gratuité enseignement (2019–2025) ; MSPHPS gratuité maternité ; Fonds Social RDC STEP/THIMO

⁸² Gouvernement RDC — Stratégie nationale de la protection sociale (SNPS), 2016

⁸³ Annexe A.1 — Classification niveau 3 : dispositifs mentionnés à titre contextuel

Chapitre 4 — Couverture effective et prestations

4.2 — Protection dans la vieillesse

Bénéficiaires de pensions de vieillesse

La branche vieillesse constitue la principale branche de long terme des régimes contributifs en RDC. Elle couvre les travailleurs du secteur privé via la CNSS et les agents publics via la CNSSAP. Le tableau suivant retrace l'évolution du nombre de pensionnés de vieillesse sur la période 2019–2025.

► **Tableau 4.1 — Bénéficiaires de pensions de vieillesse, CNSS et CNSSAP (2019–2025) [src]⁸⁴**

Institution	Prestation	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CNSS	Pension de retraite (bénéf.)	38 641	39 465	42 407	44 094	[N/D]	[N/D]	[N/D]
CNSS	Pension de retraite anticipée (bénéf.)	0	78	272	1 235	[N/D]	[N/D]	[N/D]
CNSSAP	Pension de vieillesse (bénéf.)	0	814	780	4 982	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Régimes spéciaux	Pension de vieillesse (bénéf.)	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]

Source : ESS OIT — CNSS (2019–2022) et CNSSAP (2020–2022). Régimes spéciaux (FARDC, magistrats, parlementaires) : données non disponibles — à instruire. Note : Les valeurs CNSSAP pour 2019 sont indisponibles car l'institution n'avait pas encore transmis d'ESS pour cet exercice. La forte progression entre 2020 (814 pensionnés) et 2022 (4 982) reflète les premières vagues de liquidation de droits à pension depuis la création de la CNSSAP en 2015.

Adéquation des pensions de vieillesse

L'adéquation des pensions est appréciée par leur rapport au seuil de pauvreté national. Le tableau présente les montants unitaires de pension et le seuil de pauvreté de référence pour la même période.

► **Tableau 4.2 — Adéquation des pensions de vieillesse, CNSS (2019–2025) [src]⁸⁵**

Indicateur	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pension CNSS — montant unitaire (CDF/mois)	180 000	220 000	320 000	320 000	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Seuil de pauvreté (CDF/mois, estimation)	[contexte_macro]	[contexte_macro]	[contexte_macro]	[contexte_macro]	[N/D]	[N/D]	[N/D]

Source : ESS OIT — CNSS ; seuil de pauvreté : estimation à construire à partir des données INS.

4.3 — Protection des personnes en âge actif

Couverture des travailleurs — cotisants actifs

Les régimes contributifs couvrent les travailleurs du secteur formel. Le tableau présente l'évolution du nombre d'employeurs enregistrés et de cotisants actifs auprès de la CNSS et de la CNSSAP sur la période 2019–2025.

⁸⁴ Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

⁸⁵ Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

► **Tableau 4.3 — Employeurs enregistrés et cotisants actifs, CNSS et CNSSAP (2019–2025) [src]⁸⁶**

Institution	Indicateur	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CNSS	Employeurs enregistrés	[ESS 2019]	[ESS 2020]	[ESS 2021]	[ESS 2022]	[N/D]	[N/D]	[N/D]
CNSS	Cotisants actifs (total)	676 179	508 708	591 130	613 761	[N/D]	[N/D]	[N/D]
CNSSAP	Cotisants actifs (total)	0	0	190 545	198 399	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Régimes spéciaux	Cotisants actifs (total)	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]

Source : ESS OIT — CNSS (2019–2022) et CNSSAP (2020–2022). Régimes spéciaux (FARDC, magistrats, parlementaires) : données non disponibles — à instruire.

Protection maternité

La protection maternité de la CNSS comprend trois prestations distinctes : l'indemnité journalière (compensation du salaire pendant le congé), l'allocation de maternité (forfait à la naissance) et les allocations prénatales (versées avant l'accouchement).

► **Tableau 4.4 — Bénéficiaires de prestations maternité, CNSS (2019–2025) [src]⁸⁷**

Indicateur	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bénéf. indemnité journalière maternité (CNSS)	0	2	2	17	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Bénéf. allocation de maternité (CNSS)	0	108	167	414	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Bénéf. allocations prénatales (CNSS)	0	162	184	532	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Bénéf. maternité — régimes spéciaux	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]

Source : ESS OIT — CNSS. Régimes spéciaux : données non disponibles.

Note méthodologique — faiblesse des chiffres de maternité CNSS : Les effectifs de bénéficiaires de prestations maternité déclarés par la CNSS sont très faibles au regard du nombre de cotisantes actives (moins de 1 % des assurées sur la période). Cette anomalie reflète probablement une sous-déclaration des congés maternité auprès de l'institution, une méconnaissance des droits par les assurées, ou des délais de remboursement qui découragent les demandes. Elle ne doit pas être interprétée comme un faible recours aux soins obstétricaux. Un encadré méthodologique spécifique est prévu dans le bulletin pour documenter cette limite.

Accidents du travail et maladies professionnelles

Les accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) donnent droit à une rente d'incapacité permanente pour le travailleur victime, ou à une rente de survie pour ses ayants droit en cas de décès. Le montant unitaire mensuel est identique pour toutes les rentes AT/MP d'une même année, fixé par arrêté.

► **Tableau 4.5 — Bénéficiaires de rentes d'accidents du travail et maladies professionnelles, CNSS (2019–2025) [src]⁸⁸**

Indicateur	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rentes/allocations incapacité AT/MP (CNSS)	1 082	1 020	955	1 053	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Rentes AT/MP — régimes spéciaux	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]

⁸⁶ Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

⁸⁷ Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

⁸⁸ Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

Indicateur	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de réadaptation fonctionnelle (CNSS)	[N/D]	[N/D]	[N/D]	0	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Montant unitaire rente AT/MP (CDF/mois)	180 000 CDF	220 000 CDF	320 000 CDF	320 000 CDF	[N/D]	[N/D]	[N/D]

Source : ESS OIT — CNSS (2019–2022). Régimes spéciaux : données non disponibles.

Note méthodologique — Couverture AT/MP et dénominateur : Le taux de couverture en accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) est calculé en rapportant le nombre de cotisants/assurés actifs AT/MP à la population en emploi (et non à la population active). Cette correction méthodologique exclut les chômeurs, qui ne courent par définition aucun risque d'accident du travail. Le résultat est exprimé en % de la population totale, conformément aux standards OIT. Cette approche harmonise le traitement de l'indicateur AT/MP avec celui de l'indicateur handicap/invalidité (ODD 1.3.1). Pour plus de détails, voir section 5 (Indicateurs ODD).

4.4 — Protection des enfants et des familles

Allocations familiales — régimes contributifs

Les allocations familiales constituent, en termes de volume de bénéficiaires, la prestation la plus importante de la CNSS. Elles bénéficient aux enfants des travailleurs assurés du secteur privé, sous conditions d'éligibilité définies par la législation nationale.

► **Tableau 4.6 — Enfants couverts par les allocations familiales, CNSS et CNSSAP (2019–2025) [src]⁸⁹**

Institution	Indicateur	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CNSS	Enfants couverts (allocations familiales)	267 445	294 346	396 399	356 423	[N/D]	[N/D]	[N/D]
CNSSAP	Enfants couverts (allocations familiales)	[N/D]	[N/D]	[N/D]	0	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Régimes spéciaux	Enfants couverts (allocations familiales)	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]

Source : ESS OIT — CNSS (2019–2022) et CNSSAP (2020–2022). Régimes spéciaux : données non disponibles — à instruire.

Adéquation des allocations familiales

L'allocation familiale est versée mensuellement par enfant à charge. Le tableau présente l'évolution du montant unitaire de cette allocation et le seuil de pauvreté par personne pour la même période.

► **Tableau 4.7 — Montant de l'allocation familiale CNSS et seuil de pauvreté de référence (2019–2025) [src]⁹⁰**

Indicateur	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Montant allocation familiale CNSS (CDF/mois)	—	—	—	—	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Seuil de pauvreté par personne (CDF/mois)	[contexte_macro]	[contexte_macro]	[contexte_macro]	[contexte_macro]	[N/D]	[N/D]	[N/D]

Source : ESS OIT — CNSS ; seuil de pauvreté : estimation à construire à partir des données INS.

⁸⁹ Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

⁹⁰ Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

Programmes non contributifs ciblant enfants et familles

Le tableau recense les programmes d'assistance sociale non contributifs ciblant les enfants et les ménages, ainsi que les données de couverture disponibles pour la période considérée.

► **Tableau 4.8 — Programmes non contributifs ciblant les enfants et les familles [src]⁹¹**

Programme	Gestionnaire	Bénéficiaires (dernière année connue)	Montant moyen	Source
[Programme 1 — à compléter]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	0
[Programme 2 — à compléter]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	0

4.5 — Protection en cas d'invalidité

Pensions d'invalidité — régimes contributifs

La branche invalidité couvre les assurés reconnus en incapacité permanente de travail, sous conditions de durée de cotisation préalable. Le tableau présente l'évolution du nombre de pensionnés et du montant unitaire de la pension d'invalidité.

► **Tableau 4.9 — Bénéficiaires de pensions d'invalidité, CNSS et CNSSAP (2019–2025) [src]⁹²**

Institution	Indicateur	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CNSS	Pensionnés invalidité (total)	883	568	524	728	[N/D]	[N/D]	[N/D]
CNSSAP	Pensionnés invalidité (total)	[N/D]	[N/D]	[N/D]	0	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Régimes spéciaux	Pensionnés invalidité (total)	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]
CNSS	Montant unitaire pension invalidité (CDF/mois)	[ESS 2019]	[ESS 2020]	[ESS 2021]	[ESS 2022]	[N/D]	[N/D]	[N/D]

Source : ESS OIT — CNSS (2019–2022) et CNSSAP (2020–2022). Régimes spéciaux : données non disponibles — à instruire.

Adéquation de la pension d'invalidité

Dans les régimes de la CNSS, la pension d'invalidité et la pension de vieillesse sont fixées au même montant unitaire mensuel par arrêté. Le tableau présente ces montants et le seuil de pauvreté de référence pour la même période.

► **Tableau 4.10 — Adéquation de la pension d'invalidité CNSS et seuil de pauvreté (2019–2025) [src]⁹³**

Indicateur	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pension invalidité CNSS (CDF/mois)	180 000	220 000	320 000	320 000	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Pension vieillesse CNSS (CDF/mois)	180 000	220 000	320 000	320 000	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Seuil de pauvreté (CDF/mois)	[contexte_macro]	[contexte_macro]	[contexte_macro]	[contexte_macro]	[N/D]	[N/D]	[N/D]

Source : ESS OIT — CNSS ; seuil de pauvreté : estimation à construire à partir des données INS.

⁹¹ Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

⁹² Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

⁹³ Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

Programmes non contributifs pour les personnes handicapées

Le tableau recense les programmes d'assistance sociale destinés aux personnes handicapées et les données de couverture disponibles pour la période considérée.

► **Tableau 4.11 — Programmes non contributifs pour les personnes handicapées [src]⁹⁴**

Programme	Gestionnaire	Bénéficiaires	Source
[À compléter]	[N/D]	[N/D]	[N/D]

4.6 — Protection en cas de décès et prestations de survie

Pensions de survie et prestations aux ayants droit

Les prestations de survie sont versées aux ayants droit d'un assuré décédé — conjoint survivant et orphelins principalement. La CNSS distingue la pension de survie contributive, les rentes liées aux accidents du travail et une allocation pour frais funéraires.

► **Tableau 4.12 — Bénéficiaires de prestations de survie, CNSS et CNSSAP (2019–2025) [src]⁹⁵**

Institution	Prestation	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CNSS	Pension des survivants (bénéf.)	24 725	25 720	28 355	31 524	[N/D]	[N/D]	[N/D]
CNSS	Rentes de survivants AT/MP (bénéf.)	1 476	1 608	1 845	1 781	[N/D]	[N/D]	[N/D]
CNSS	Allocation frais funéraires (bénéf.)	1 766	589	849	533	[N/D]	[N/D]	[N/D]
CNSSAP	Pension des survivants (bénéf.)	0	90	217	6 964	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Régimes spéciaux	Pension des survivants (bénéf.)	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]

Source : ESS OIT — CNSS (2019–2022) et CNSSAP (2020–2022). Régimes spéciaux : données non disponibles — à instruire.

Adéquation des pensions de survie

Le tableau présente les montants unitaires de pension de survie et de pension de vieillesse du même régime, ainsi que le seuil de pauvreté de référence pour la même période.

► **Tableau 4.13 — Adéquation des pensions de survie CNSS et seuil de pauvreté (2019–2025) [src]⁹⁶**

Indicateur	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pension survie CNSS (CDF/mois)	180 000	220 000	320 000	320 000	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Pension vieillesse CNSS (CDF/mois)	180 000	220 000	320 000	320 000	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Montant frais funéraires CNSS (CDF)	180 000	220 000	320 000	320 000	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Seuil de pauvreté (CDF/mois)	[contexte_macro]	[contexte_macro]	[contexte_macro]	[contexte_macro]	[N/D]	[N/D]	[N/D]

Source : ESS OIT — CNSS ; seuil de pauvreté : estimation à construire à partir des données INS.

⁹⁴ Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

⁹⁵ Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

⁹⁶ Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

4.7 — Protection en matière de santé

La protection de la santé en RDC s'organise autour de trois types de dispositifs : un régime national d'assurance maladie à double composante contributive et non contributive (FSS), un régime statutaire obligatoire pour les enseignants (MESP), et un secteur de mutuelles de santé volontaires sans données statistiques consolidées à ce stade. Ces dispositifs coexistent sans qu'un système d'enregistrement commun permette d'en agréger la couverture effective à l'échelle nationale.

Le FSS — Fonds de Solidarité de Santé

Institué par la loi n°18/035 du 13 décembre 2018 et organisé par le décret n°22/13 du 9 avril 2022, le FSS est la caisse nationale d'assurance maladie de la RDC.⁹⁷ Il est devenu opérationnel en 2022 et constitue l'un des instruments de mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Il propose trois produits : Afia Bora (paquet de base obligatoire, régime contributif pour les travailleurs du secteur formel), Afia Bora Prime (paquet complémentaire contributif), et Kobota Ofele (programme d'assistance de l'État pour les mères et les nouveau-nés, financement non contributif).

► Tableau 4.14 — Indicateurs de couverture FSS (2019–2025)

Indicateur	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Affiliés FSS — régime contributif	[N/A]	[N/A]	[N/A]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Cotisants actifs FSS	[N/A]	[N/A]	[N/A]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Bénéficiaires Afia Bora	[N/A]	[N/A]	[N/A]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Bénéficiaires Kobota Ofele (non contributif)	[N/A]	[N/A]	[N/A]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Dépenses de prestations (CDF)	[N/A]	[N/A]	[N/A]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]

[N/A] = institution non encore opérationnelle. [N/D] = donnée non disponible — à extraire des ESS ou à collecter auprès du FSS. Source : ESS OIT — FSS 2022 ; FSS, fss.cd, juin 2026.

La MESP — Mutuelle des Enseignants de l'EPST

La Mutuelle des Enseignants de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (MESP) est un régime de santé statutaire obligatoire antérieur au FSS. Elle couvre les enseignants relevant du ministère de l'EPST selon un mécanisme contributif. Les ESS disponibles portent sur les exercices 2019 à 2022.

► Tableau 4.15 — Indicateurs de couverture MESP (2019–2025)

Indicateur	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Affiliés MESP	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Cotisants actifs MESP	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Bénéficiaires couverts	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Dépenses de prestations (CDF)	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]

⁹⁷ Source : FSS RDC — Site officiel fss.cd, consulté juin 2026 — Loi n°18/035 du 13 décembre 2018 ; Décret n°22/13 du 09 avril 2022

Source : ESS OIT — MESP 2019–2022 (fichiers disponibles, données à extraire). Données 2023–2025 : à collecter auprès de la MESP.

Mutuelles de santé volontaires

Les mutuelles de santé à adhésion volontaire constituent un troisième niveau de protection. Elles incluent notamment les structures d'assurance médicale du secteur privé (type SESOPA pour les secteurs pétrolier et bancaire) ainsi que les mutuelles communautaires et associatives. Ces dispositifs sont mentionnés à titre contextuel : ils ne font pas l'objet d'une collecte statistique consolidée dans le cadre de la présente édition du bulletin et leurs données de couverture ne sont pas agrégées dans les indicateurs.

4.8 — Dépenses et financement du système

Recettes des régimes contributifs

Les recettes des régimes contributifs proviennent principalement des cotisations salariales et patronales. Le financement des régimes non contributifs repose sur les transferts du budget de l'État et les contributions des partenaires au développement.

► **Tableau 4.16 — Recettes des régimes contributifs (2019–2025) [src]⁹⁸**

Institution	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CNSS — recettes totales (milliards CDF)	577,8 Mds CDF	725,7 Mds CDF	926,5 Mds CDF	1067,8 Mds CDF	[N/D]	[N/D]	[N/D]
CNSSAP — recettes totales (milliards CDF)	0	40,5 Mds CDF	41,6 Mds CDF	52,4 Mds CDF	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Régimes spéciaux — recettes totales (milliards CDF)	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Programmes non contributifs — financement public	[N/D]	[N/D]	[N/D]	0	[N/D]	[N/D]	[N/D]

Source : ESS OIT — CNSS et CNSSAP. Régimes spéciaux : données non disponibles — à instruire.

Dépenses de prestations

Les dépenses de prestations correspondent aux transferts effectifs versés aux bénéficiaires — pensions, allocations, rentes, indemnités. Elles sont distinguées des dépenses administratives, conformément aux standards de l'OIT. Les valeurs sont exprimées en milliards de francs congolais courants.

► **Tableau 4.17 — Dépenses de prestations par institution (2019–2025) [src]⁹⁹**

Institution	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CNSS — dépenses de prestations (milliards CDF)	328,5 Mds CDF	436,5 Mds CDF	493,2 Mds CDF	677,8 Mds CDF	[N/D]	[N/D]	[N/D]
CNSSAP — dépenses de prestations (milliards CDF)	0	7,2 Mds CDF	8,5 Mds CDF	34,4 Mds CDF	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Régimes spéciaux — dépenses de prestations (milliards CDF)	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]

⁹⁸ Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

⁹⁹ Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

Source : ESS OIT — CNSS et CNSSAP. Régimes spéciaux : données non disponibles — à instruire.

Dépenses administratives et ratio d'efficience

► **Tableau 4.18 — Dépenses administratives et ratio d'efficience (2019–2025) [src]¹⁰⁰**

Institution	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CNSS — dépenses administratives (milliards CDF)	[N/D]	[N/D]	[N/D]	0	[N/D]	[N/D]	[N/D]
CNSS — ratio admin / dépenses totales (%)	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[N/D]	[N/D]	[N/D]
CNSSAP — dépenses administratives (milliards CDF)	0	5,6 Mds CDF	6,9 Mds CDF	14,0 Mds CDF	[N/D]	[N/D]	[N/D]
CNSSAP — ratio admin / dépenses totales (%)	0	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Régimes spéciaux — dépenses administratives	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]

Source : ESS OIT — CNSS et CNSSAP. Le ratio est calculé comme : dépenses administratives / (dépenses de prestations + dépenses administratives). Régimes spéciaux : données non disponibles.

Dépenses en proportion du PIB

Le rapport des dépenses de protection sociale au PIB est calculé pour permettre des comparaisons temporelles et internationales. Les valeurs de référence pour l'Afrique subsaharienne et la moyenne mondiale sont issues du World Social Protection Report de l'OIT.

► **Tableau 4.19 — Dépenses de protection sociale en proportion du PIB (2019–2025) [src]¹⁰¹**

Indicateur	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dépenses PS totales (CNSS + CNSSAP) / PIB (%)	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Dépenses PS (y.c. rég. spéciaux si données disponibles) / PIB (%)	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]
Moyenne Afrique subsaharienne / PIB (%)	—	—	[WSPR]	[WSPR]	—	—	—
Moyenne mondiale / PIB (%)	—	—	[WSPR]	[WSPR]	—	—	—

Source : ESS OIT ; PIB RDC : Banque mondiale WDI ; comparaisons : World Social Protection Report OIT.

¹⁰⁰ Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

¹⁰¹ Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

Chapitre 5 — Positionnement de la RDC au regard des indicateurs ODD

5.1 — ODD 1.3.1 : couverture par les régimes de protection sociale

Définition et méthodologie

L'indicateur ODD 1.3.1 mesure la proportion de la population effectivement couverte par au moins une prestation de protection sociale. Il est calculé selon la méthodologie de l'OIT, qui distingue la couverture légale (droit formel à une prestation) de la couverture effective (bénéfice réel d'une prestation). Seule la couverture effective est retenue ici.

L'indicateur est décomposé par groupe de population conformément aux catégories officielles de l'OIT :

► **Tableau 5.1 — Définitions des sous-indicateurs de l'ODD 1.3.1 [src]**¹⁰²

Sous-indicateur ODD 1.3.1	Définition
Population totale	% de la population couverte par au moins une prestation
Enfants (0–14 ans)	% couverts par une prestation enfance/famille
Femmes ayant accouché	% couvertes par une prestation maternité
Personnes âgées	% recevant une pension de vieillesse
Actifs / contributeurs	% cotisant à un régime contributif
Personnes handicapées	% recevant une prestation invalidité
Accidents du travail et maladies professionnelles	% de la population en emploi couverte contre les risques professionnels

Résultats pour la RDC

Note méthodologique : À partir de la présente édition, le sous-indicateur AT/MP (accidents du travail et maladies professionnelles) est calculé selon la méthodologie révisée du BIT : le numérateur (assurés actifs AT/MP) est rapporté à la population en emploi (et non à la population active), et le résultat est exprimé en % de la population totale (conformément aux standards ODD 1.3.1). Cette correction assure la comparabilité avec d'autres indicateurs de couverture et exclut les chômeurs, qui ne courent aucun risque professionnel. Pour plus de détails, voir l'encadré méthodologique à la fin de la section 4.3.

► **Tableau 5.2 — Valeurs de l'ODD 1.3.1 pour la RDC par groupe de population (2019–2025) [src]**¹⁰³

Sous-indicateur ODD 1.3.1	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Population totale (%)	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]
Enfants 0–14 ans (%)	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]
Femmes ayant accouché — maternité (%)	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]

¹⁰² Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

¹⁰³ Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

Sous-indicateur ODD 1.3.1	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personnes âgées — pension vieillesse (%)	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]
Actifs — contributeurs (%)	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]
Personnes handicapées — invalidité (%)	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]
Personnes en emploi — AT/MP (%)	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]	[EST.]

Source : calculs à partir des ESS OIT (CNSS 2019–2022, CNSSAP 2020–2022) et des données démographiques ONU WPP. Les estimations [EST.] seront calculées par le script `generer_figures_ch4.py` depuis la base.

Comparaison régionale et internationale

► **Tableau 5.3 — Comparaison régionale et internationale de l'ODD 1.3.1 [src]¹⁰⁴**

Pays / Région	ODD 1.3.1 — population totale (%)	Année	Source
RDC	[EST.]	2022	ESS OIT / calcul
Angola	[WSPR]	—	World Social Protection Report OIT
Mozambique	[WSPR]	—	World Social Protection Report OIT
Afrique subsaharienne (moyenne)	[WSPR]	—	World Social Protection Report OIT
Monde (moyenne)	[WSPR]	—	World Social Protection Report OIT

Source : World Social Protection Report OIT (2024–26) ; ILOSTAT.

Trajectoire et objectifs

► **Tableau 5.4 — Trajectoire et objectifs de l'indicateur ODD 1.3.1 pour la RDC [src]¹⁰⁵**

Indicateur	2022 (référence)	2025 (cible PNPS)	2030 (cible ODD)
ODD 1.3.1 — population totale (%)	[EST.]	[N/D — cible PNPS à rechercher]	—

5.2 — ODD 3.8.1 : couverture sanitaire universelle

Définition et méthodologie

L'indicateur ODD 3.8.1 mesure l'indice de couverture des services de santé essentiels, calculé par l'OMS à partir d'une sélection de services traceurs couvrant la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile, les maladies infectieuses, les maladies non transmissibles et la capacité d'accès aux soins. Il est exprimé sur une échelle de 0 à 100. Il complète l'ODD 1.3.1 : là où ce dernier mesure la couverture par les régimes de protection sociale, l'ODD 3.8.1 mesure l'accès effectif aux services de santé, indépendamment du mécanisme de financement.

Résultats pour la RDC

► **Tableau 5.5 — Évolution de l'indice ODD 3.8.1 pour la RDC (2015–2023) [src]¹⁰⁶**

Indicateur	2015	2017	2019	2021	2023
Indice ODD 3.8.1 — RDC (0–100)	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]	[N/D]

Source : OMS, Global Health Observatory, indicateur UHC Service Coverage Index (SDG 3.8.1) — données à collecter sur data.who.int.

¹⁰⁴ Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

¹⁰⁵ Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

¹⁰⁶ Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

Comparaison régionale et internationale

► **Tableau 5.6 — Comparaison régionale et internationale de l'ODD 3.8.1 [src]¹⁰⁷**

Pays / Région	Indice ODD 3.8.1 (0–100)	Année	Source
RDC	[N/D]	—	OMS GHO
Angola	[N/D]	—	OMS GHO
Mozambique	[N/D]	—	OMS GHO
Afrique subsaharienne (moyenne)	[N/D]	—	OMS GHO
Monde (moyenne)	[N/D]	—	OMS GHO

Source : OMS, Global Health Observatory.

Trajectoire et objectifs

► **Tableau 5.7 — Trajectoire et objectifs de l'indicateur ODD 3.8.1 pour la RDC [src]¹⁰⁸**

Indicateur	Valeur de référence	2030 (cible ODD)
Indice ODD 3.8.1 — RDC (0–100)	[N/D]	80

Note : la cible ODD 3.8.1 est fixée à 80 (sur 100) pour 2030. La valeur nationale de référence sera renseignée à partir des données OMS GHO.

¹⁰⁷ Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

¹⁰⁸ Source : ESS OIT — tableaux statistiques standardisées

Chapitre 6 — Qualité, disponibilité et perspectives

Annexe A — Notes méthodologiques

A.1 — Champ de la protection sociale et critères d'inclusion statistique

Un périmètre défini par la finalité protectrice et la mesurabilité

Le champ statistique du bulletin est délimité à partir de deux critères cumulatifs : la **finalité protectrice** du dispositif et la **mesurabilité statistique** des données qu'il produit.

Le critère de finalité protectrice exige que le dispositif ait pour objet principal de couvrir une personne ou un ménage contre un risque social identifié — maternité, maladie, accident du travail, invalidité, vieillesse, décès du soutien de famille, chômage, pauvreté ou vulnérabilité de revenu¹⁰⁹. Ce critère écarte les dispositifs dont l'effet protecteur est indirect, accessoire ou non garanti, tels que certaines politiques d'investissement public ou d'accès aux infrastructures.

Le critère de mesurabilité exige qu'il soit possible d'identifier, à partir des données disponibles, au moins l'une des grandeurs statistiques suivantes : des personnes couvertes ou affiliées, des cotisants actifs, des bénéficiaires, des prestations servies ou des dépenses. Ce critère écarte les dispositifs pour lesquels aucune donnée individuelle ou agrégée ne permet de quantifier la couverture réelle, même si leur finalité protectrice est indéniable.

Ces deux critères ne constituent pas une liste fermée de dispositifs admis ou exclus. Ils définissent une règle opérationnelle permettant de statuer sur chaque dispositif de façon cohérente et documentée.

Trois niveaux de traitement dans le bulletin

Sur la base de ces critères, le bulletin distingue trois niveaux de traitement des dispositifs.

Niveau 1 — Dispositifs intégrés dans les indicateurs statistiques. Sont classés à ce niveau les régimes et programmes pour lesquels les deux critères sont satisfaits : finalité protectrice établie et données disponibles permettant de mesurer la couverture. Entrent notamment dans ce groupe les régimes contributifs de sécurité sociale gérés par des institutions formelles (*CNSS, CNSSAP, régimes spéciaux*) et les programmes non contributifs disposant de données de ciblage, d'enregistrement ou de paiement documentées¹¹⁰.

Niveau 2 — Dispositifs traités séparément. Sont classés à ce niveau les dispositifs dont la finalité protectrice est établie mais pour lesquels les données ne permettent pas encore de produire des indicateurs comparables. Ils sont présentés de façon descriptive, avec les données disponibles, sans être agrégés dans les indicateurs globaux de couverture. La couverture sanitaire universelle entre, selon l'état d'avancement des données, dans cette catégorie.

Niveau 3 — Dispositifs mentionnés à titre contextuel. Sont classés à ce niveau les dispositifs dont la finalité protectrice est reconnue mais qui ne donnent pas lieu à des prestations individualisables ou à des données de couverture. Ils sont mentionnés pour la complétude du tableau institutionnel, sans influencer sur les indicateurs. C'est le cas de certains services sociaux,

¹⁰⁹ Source : OIT — Convention no 102 (1952) — les neuf branches de risques : maternité, maladie, accident du travail, invalidité, vieillesse, décès, chômage, Parties II à X

¹¹⁰ Source : OIT — Recommandation no 202 (2012) — les programmes non contributifs font partie intégrante de la protection sociale

gratuités sectorielles, dispositifs d'urgence ou programmes d'accompagnement social dont le périmètre et les bénéficiaires ne sont pas documentés de façon consolidée.

Un périmètre évolutif

La classification d'un dispositif dans l'un de ces trois niveaux n'est pas définitive. Elle reflète l'état des données disponibles au moment de la préparation du bulletin et est susceptible d'évoluer à mesure que les systèmes d'information des institutions s'améliorent et que de nouvelles données deviennent accessibles. Le passage d'un dispositif du niveau 2 au niveau 1, ou du niveau 3 au niveau 2, constitue en soi un indicateur de progrès dans la gouvernance statistique de la protection sociale en RDC.

A.2 — Classification des régimes, programmes et prestations

Couverture légale et couverture effective

Le bulletin articule deux notions hiérarchiquement liées, non interchangeables.

La **couverture légale** désigne les personnes ou catégories de personnes auxquelles un régime ou un programme est applicable selon les textes juridiques, réglementaires ou statutaires en vigueur. Elle est une condition nécessaire : on ne peut bénéficier d'une protection effective sans que celle-ci soit d'abord prévue par un texte. Elle n'est pas suffisante : un dispositif peut être légalement prévu sans être effectivement mis en œuvre, faute d'affiliation systématique, de ressources, ou de données disponibles.

La **couverture effective** désigne les personnes réellement protégées : affiliées et cotisantes, ou ayant effectivement reçu une prestation au cours de la période de référence, selon des données administratives ou d'enquête. Une couverture effective est nécessairement aussi légale : elle en est le sous-ensemble mis en œuvre. C'est cet angle statistique qui constitue le principal objet de mesure du présent bulletin.

Nature des régimes et programmes

Les dispositifs de protection sociale se différencient selon plusieurs dimensions de classification.

Selon le caractère obligatoire ou volontaire de l'affiliation. Les régimes légalement obligatoires concernent des catégories de travailleurs ou de résidents définis par la loi et gèrent une affiliation de droit. Les dispositifs à adhésion volontaire — mutuelles, assurances privées, épargne retraite individuelle — fonctionnent sur la base d'un consentement individuel ou collectif. [C102, art. 6]¹¹¹

Selon la nature du financement. Les régimes **contributifs** sont financés principalement par des cotisations de l'employeur et du travailleur, proportionnelles aux revenus d'activité. Les dispositifs **non contributifs** sont financés par l'État ou par des partenaires extérieurs, sans cotisation préalable de la personne protégée. Ces deux modes de financement peuvent coexister au sein d'un même système national et doivent être traités comme complémentaires. [R202, par. 5]¹¹²

¹¹¹ OIT - Convention no 102 (1952) - art. 6 : assurance volontaire supervisée par l'État

¹¹² OIT - Recommandation no 202 (2012) - par. 5 : les socles peuvent être mis en œuvre par des transferts contributifs ou non contributifs

Selon le statut réglementaire. Les régimes **statutaires** sont créés et régis par des textes législatifs ou réglementaires formels. Les dispositifs **non statutaires** — programmes sociaux à durée limitée, transferts conditionnels, projets d'appui — opèrent dans un cadre plus souple, souvent sans base légale permanente. Cette distinction est pertinente pour apprécier la pérennité institutionnelle d'un dispositif. [OIT 2021]¹¹³

Selon la nature des prestations. Les prestations **en espèces** (pensions, indemnités, allocations) procurent un revenu ou compensent une perte de revenu. Les prestations **en nature** (soins de santé, équipements, services) procurent directement un bien ou un service. Cette distinction est importante pour la lecture des indicateurs de dépenses et de bénéficiaires. [C102, art. 1]¹¹⁴

Conditions d'accès aux prestations

Les conditions d'accès varient selon la nature du dispositif et structurent la répartition réelle de la couverture. Le bulletin distingue les principaux modes d'accès suivants :

- **Affiliation et cotisation** : accès subordonné à l'enregistrement préalable dans un régime et au versement de cotisations sur une durée minimale. Applicable aux régimes contributifs obligatoires (CNSS, CNSSAP).
- **Statut professionnel ou catégoriel** : accès réservé à une catégorie définie de travailleurs (agents publics, militaires, policiers, magistrats, enseignants). Applicable aux régimes spéciaux.
- **Condition de ressources** : accès subordonné à un niveau de revenu ou à une situation de pauvreté documentée. Applicable aux programmes sociaux ciblés.
- **Ciblage catégoriel** : accès réservé à une catégorie démographique ou de vulnérabilité définie sans condition de revenu explicite.
- **Résidence** : accès lié au fait de résider sur un territoire donné, indépendamment du statut professionnel ou économique.
- **Accès universel ou quasi universel** : accès non conditionné, ouvert à l'ensemble de la population ou d'un groupe très large, sans critère d'éligibilité restrictif.

Ces conditions d'accès ont une incidence directe sur les indicateurs de couverture : deux régimes couvrant formellement le même risque peuvent produire des taux de couverture très différents selon les conditions qu'ils imposent et la capacité institutionnelle à les faire respecter.

¹¹³ OIT (2021) - Building social protection systems - cadre analytique des dispositifs statutaires et non statutaires

¹¹⁴ OIT - Convention no 102 (1952) - art. 1 par. 2 : la prestation peut être directe (en nature) ou indirecte (remboursement)

Annexe B — Fiches institutionnelles détaillées

B.1 Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)

Cadre juridique et institutionnel

Élément	Détail
Texte fondateur	Décret-loi n° 87-021 du 5 août 1987 portant organisation de la sécurité sociale
Tutelle ministérielle	Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Statut juridique	Établissement public à caractère social
Année de création	1987 (refonte du régime de sécurité sociale)

Mission et branches couvertes

La CNSS a pour mission de coordonner et d'administrer les prestations de sécurité sociale pour les travailleurs du secteur privé formel et leurs ayants droit.

Branche	Couverte ?	Note
Vieillesse, invalidité, décès		Pension de vieillesse normale, proportionnelle, anticipée, de survivant ; allocation de décès
Accidents du travail / maladies professionnelles (AT/MP)		Rentes d'incapacité, rentes de survivant
Prestations familiales		Allocations familiales
Maternité		Indemnités de maternité
Soins de santé		Non gérée directement par la CNSS
Chômage		Non couverte

Population assujettie : travailleurs salariés du secteur privé (formel), congolais et étrangers, exerçant sur le territoire national.

Données de couverture

Indicateur	2019	2020	2021	2022	2023
Affiliés enregistrés					
Cotisants actifs (contributeurs)	676 179	508 708	591 130	613 761	
Bénéficiaires de pensions (vieillesse + invalidité)					
Bénéficiaires AT/MP (rentes d'incapacité)	1 082	1 020	955	1 053	
Bénéficiaires AT/MP (rentes de survivant)	1 476	1 608	1 845	1 781	

Indicateur	2019	2020	2021	2022	2023
Bénéficiaires d'allocations familiales					

Sources : premier Bulletin statistique RDC (2023) pour 2019-2022. Données 2023 à transmettre par la CNSS.

Évolutions et réformes en cours

Le nombre de cotisants actifs à la CNSS a enregistré une baisse significative en 2020 (24,7 %), passant de 676 179 à 508 708, sous l'effet de la pandémie de COVID-19. Une reprise progressive a été observée dès 2021 (+16,2 %), puis en 2022 (+3,8 %), portant le total à 613 761 cotisants. La couverture n'a cependant pas encore retrouvé son niveau d'avant-crise.

[À compléter : réformes législatives récentes, extension géographique, informatisation du registre, etc.]

B.2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publics de l'État (CNSSAP)

Cadre juridique et institutionnel

Élément	Détail
Texte fondateur	Décret n° 15/031 du 14 décembre 2015
Tutelle ministérielle	Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Statut juridique	Établissement public à caractère administratif
Année de création	2015

Mission et branches couvertes

La CNSSAP a pour mission de coordonner et d'administrer les prestations de sécurité sociale pour les agents publics de l'État et leurs ayants droit.

Branche	Couverte ?	Note
Vieillesse, invalidité, décès		En cours de déploiement
Accidents du travail / maladies professionnelles (AT/MP)		Branche officiellement lancée en mai 2023
Prestations familiales		
Maternité		
Soins de santé		Non gérée directement
Chômage		Non couverte

Population assujettie : agents de carrière des services publics de l'État, fonctionnaires contractuels, stagiaires et apprentis sous contrat. Les militaires et policiers relèvent de régimes spéciaux distincts.

Données de couverture

Indicateur	2019	2020	2021	2022	2023
Contributeurs actifs (total)	172 204			198 399	
dont hommes	110 912			138 443	
dont femmes		65 624			
Bénéficiaires de pensions					

Indicateur	2019	2020	2021	2022	2023
Bénéficiaires AT/MP					

Sources : premier Bulletin statistique RDC (2023) pour 2019-2022. Données 2023 à transmettre par la CNSSAP.

Évolutions et réformes en cours

Mécanisation des agents publics. La RDC est confrontée depuis plusieurs décennies au problème des agents et fonctionnaires de l'État dits non mécanisés : des agents possédant un numéro de matricule mais n'apparaissant pas sur la liste de paie officielle, ne percevant donc aucune rémunération et ne bénéficiant d'aucune prestation sociale. Une politique d'inclusion salariale progressive dite de mécanisation a été engagée pour régulariser leur situation. Entre octobre 2021 et décembre 2022, environ 40 000 agents ont été mécanisés, suivis de 101 000 agents supplémentaires.

Mise à la retraite par vagues. En 2022, le Vice-Premier Ministre en charge de la Fonction Publique a annoncé que 350 000 agents étaient éligibles à la retraite, dont certains âgés de plus de 90 ans. Des départs ont été organisés en vagues successives : 4 400 agents (septembre 2022), puis 6 369 agents (février 2023), avec une prévision de 50 000 départs supplémentaires en 2023. Ce processus représente un enjeu financier majeur pour la CNSSAP.

Lancement de la branche AT/MP. En mai 2023, la branche accidents du travail et maladies professionnelles a été officiellement lancée, étendant la couverture de la CNSSAP à l'ensemble de ses contributeurs.

[À compléter : autres réformes en cours, extension aux enseignants, déploiement du système informatique, etc.]

B.3 Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS)

Cadre juridique et institutionnel

Élément	Détail
Texte fondateur	À préciser
Tutelle ministérielle	À préciser
Statut juridique	À préciser
Année de création	À préciser

Mission et branches couvertes

[À rédiger à réception des informations du FNPSS.]

Branche	Couverte ?	Note
Vieillesse, invalidité, décès	À confirmer	
AT/MP	À confirmer	
Prestations familiales	À confirmer	
Maternité	À confirmer	
Soins de santé	À confirmer	

Population assujettie : À préciser.

Données de couverture

Indicateur	2019	2020	2021	2022	2023
Affiliés enregistrés					
Cotisants actifs					
Bénéficiaires					

Évolutions et réformes en cours

[À rédiger à réception des informations du FNPSS.]

B.4 Mutuelle de Santé des Enseignants de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (MESP)

Cadre juridique et institutionnel

Élément	Détail
Texte fondateur	Arrêté n° 027/CAB/MINETAT/MTEPS/01/2019 (agrément) ; Arrêté n° 042/CAB/MIN/JGSDH/2015 (reconnaissance)
Tutelle ministérielle	Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (MEPST)
Statut juridique	Mutuelle de santé agréée, obligatoire et statutaire
Année de création / agrément	2015 (reconnaissance) ; 2019 (agrément)

Mission et branches couvertes

La MESP est la seule mutuelle obligatoire et statutaire en RDC. Elle est une société d'assurance maladie obligatoire de type corporatif qui regroupe tous les enseignants du secteur public.

Branche	Couverte ?	Note
Soins de santé (assurance maladie)		Paquet étendu : soins ambulatoires, spécialisés, hospitaliers, médicaments, examens
Maternité		Incluse dans le paquet de soins
Vieillesse / pensions		Non couverte
AT/MP		Non couverte
Prestations familiales		Non couverte

Population assujettie : enseignants du secteur public de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi que leur conjoint et un maximum de 3 enfants de moins de 18 ans (ou encore étudiants ; 5 enfants si les deux conjoints sont enseignants). L'affiliation est conditionnée à la détention d'une carte MESP.

Données de couverture

Indicateur	2019	2020	2021	2022	2023
Contributeurs (titulaires enseignants)	50 256	54 383	60 745	80 041	
Membres de famille à charge	72 291	76 578	81 081	84 836	
Total couvert	122 547	130 961	141 826	164 877	

Source : données transmises par le MEPST (2023), reprises dans le premier Bulletin statistique RDC N°1/2023.

Évolutions et réformes en cours

Entre 2019 et 2022, le nombre de contributeurs à la MESP a progressé de **59,3 %**, passant de 50 256 à 80 041. Le nombre de personnes à charge a également augmenté, atteignant 84 836 en 2022, pour un total couvert de 164 877 personnes.

Cette dynamique reste cependant très en deçà du potentiel : si chaque enseignant détenait une carte MESP, la mutuelle compterait plus de 700 000 titulaires et potentiellement 2 800 000 bénéficiaires au total. À fin 2022, la MESP n'était opérationnelle que dans 7 des 26 provinces (Kinshasa, Haut-Katanga, Équateur, Kasai-Oriental, Kasai, Tshopo et Nord-Kivu), laissant 19 provinces sans couverture effective.

L'extension géographique progressive constitue le principal enjeu stratégique de la MESP pour les années à venir.

B.5 Fonds de Solidarité de Santé (FSS)

Cadre juridique et institutionnel

Élément	Détail
Texte fondateur	Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique
Décret d'organisation	Décret n° 22/13 du 09 avril 2022
Tutelle ministérielle	Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Statut juridique	Établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion
Année de création	2018 (loi) ; organisation précisée en 2022

Mission et branches couvertes

Le FSS est l'instrument central de la mise en œuvre de la Couverture Santé Universelle (CSU) en RDC. Il est chargé d'organiser la solidarité financière des cotisants de la CSU, de collecter les fonds, de contractualiser avec les établissements de santé et pharmaceutiques, et d'assurer un financement équitable des soins pour tous.

Le FSS a vocation à regrouper, à terme, plusieurs régimes :

Régime	Statut
Assurance maladie obligatoire pour les agents publics actifs et retraités	En cours d'opérationnalisation
Assurance maladie obligatoire pour les travailleurs du secteur privé	En cours
Assurance maladie obligatoire scolaire et estudiantine	En cours
Assurance maladie du secteur informel	En cours
Assistance médicale aux personnes vulnérables (non contributif)	En cours
Régime spécial sur la gratuité de la maternité	Opérationnel depuis septembre 2023 (Kinshasa)
Assurance maladie complémentaire	En cours

Données de couverture

Indicateur	2022	2023	Note
Bénéficiaires de la gratuité de la maternité		<i>En cours de déploiement</i>	Lancé en septembre 2023 à Kinshasa
Population cible (ville-province de Kinshasa)		1618 millions	Première phase
Contributeurs actifs			Contributions non encore prélevées

À compléter à réception des données du FSS.

Évolutions et réformes en cours

Le FSS représente l'architecture institutionnelle centrale de la CSU en RDC, mais son déploiement effectif est progressif. En septembre 2023, la politique de gratuité des accouchements et des soins néonataux a été lancée dans la ville-province de Kinshasa. Ce paquet couvre les consultations prénatales, l'échographie obstétricale, les accouchements simples et par césarienne, les soins du nouveau-né, la vaccination, les consultations post-natales et l'accès aux médicaments essentiels.

L'extension est prévue vers le Sud-Kivu, le Kasai-Oriental et le Kongo-Central, avant une généralisation progressive à l'ensemble du territoire national. La vocation du FSS est à terme de remplacer tous les régimes particuliers de financement des soins médicaux existants pour assurer une couverture universelle.

B.6 Service Autonome de Sécurité Sociale des Parlementaires (SESOPA)

Cadre juridique et institutionnel

Élément	Détail
Texte fondateur	Loi n° 88-002 du 29 janvier 1988
Autorité de tutelle	Assemblée Nationale
Statut juridique	Service autonome placé sous la responsabilité de l'Assemblée Nationale
Régime	Régime spécial contributif (partiellement)

Mission et branches couvertes

La SESOPA gère le régime de protection sociale des parlementaires nationaux.

Branche	Couverte ?	Note
Vieillesse		Pension de retraite
Décès		Allocation aux ayants droit
Invalidité		Non mentionnée explicitement
Soins de santé		Non couverte par ce régime
AT/MP		Non couverte

Population assujettie : parlementaires nationaux (Assemblée Nationale) et leurs ayants droit.

Données de couverture

Indicateur	2019	2020	2021	2022	2023
Parlementaires affiliés					
Bénéficiaires de pensions					

Données non disponibles au moment du premier bulletin. À transmettre par la SESOPA.

Évolutions et réformes en cours

[À compléter à réception des informations de la SESOPA.]

B.7 Régimes spéciaux non contributifs de la fonction publique

Ces régimes sont financés par le Trésor public et destinés à des catégories spécifiques d'agents de l'État. Leur identification exhaustive est difficile : le premier bulletin note explicitement qu'il a été impossible d'en obtenir une liste complète et des données détaillées.

Régimes identifiés

Régime	Autorité en charge	Texte juridique	Population protégée	Financement	Branches couvertes
Régime de la Présidence et Primature	Présidence de la République et Primature	Ordonnance n° 82-046 du 31 mars 1982	Agents publics de l'État et leurs ayants droit	Trésor public	Soins médicaux, indemnité de cessation de mandat, vieillesse, décès, invalidité
Régime militaire	Ministère de la Défense et des Anciens Combattants	N/A (non précisé)	Militaires et leurs ayants droit	Trésor public	Vieillesse, décès, invalidité
Régime des magistrats	Ministère de la Justice	Ordonnance-Loi n° 88-056 du 29 septembre 1988	Magistrats civils et militaires de l'ordre de justice et leurs ayants droit	Trésor public	Vieillesse, décès, invalidité

Données disponibles

Aucune donnée statistique détaillée n'a pu être obtenue pour ces régimes lors de la préparation du premier bulletin. L'obtention de données auprès des ministères de tutelle constitue un objectif prioritaire pour le présent bulletin.

Perspective de collecte

[À compléter selon les données reçues des ministères concernés : Présidence / Primature, Défense, Justice.]

Annexe B — Programmes et dispositifs hors périmètre OIT

Titre de l'annexe

Titre de l'annexe

Titre de l'annexe
